Estilo UERJ

Simulado R04 Resolução

Gabarito, a armadilha de cada questão, o dado que decide e o raciocínio completo, alternativa por alternativa.

50 questões

26 de outubro de 2026

ANTES DE CORRIGIR

Como usar esta resolução

Corrija olhando primeiro a coluna da arma. O que interessa não é o total de acertos, é em qual armadilha você caiu.

ARMA DA BANCA	O QUE FAZ	QUESTÕES	ONDE ESTÃO
Rótulo verdadeiro	um dado real do paciente puxa para a doença de manual errada	15	5, 6, 7, 8, 11, 23, 26, 28, 31, 32, 35, 36, 37, 41, 42
Negativo no meio	o discriminante é um dado negativo no meio do caso	4	9, 25, 39, 44
Droga a deduzir	a droga em uso não é nomeada	2	22, 45
Grade X / Y	alternativa composta em que uma metade não basta	14	10, 12, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 34, 38, 40, 46, 48, 50
Qualificador	o comando restringe o que se pede	2	4, 16
Limiar	um ponto de corte ou janela decide	6	2, 14, 17, 20, 29, 43
Omissão	a resposta certa é não fazer, ou o degrau mais simples	4	13, 19, 47, 49
Cronologia	o tempo entre os eventos decide	3	1, 3, 15

O que cada arma treina em você

- **Rótulo verdadeiro, negativo no meio, dado omitido:** a leitura em modo confirmação, a sua maior causa de erro de identificação.
- **Grade X / Y e qualificador:** a alternativa aceita pela metade e o comando lido pela metade.
- **Limiar, cronologia e omissão:** a regra aplicada sem checar a condição que a habilita, e o exame ou tratamento a mais, o seu padrão dominante nos Simulados 1 a 4.
- **Droga a deduzir:** a droga em uso que decide e não vem nomeada.

Todas as questões têm uma única alternativa defensável pela diretriz citada. Se discordar de alguma, anote: discutir o gabarito é o melhor treino.

GABARITO

Respostas

1 **A**	2 **B**	3 **C**	4 **D**	5 **B**	6 **C**	7 **B**	8 **C**	9 **A**	10 **D**
11 **C**	12 **B**	13 **A**	14 **B**	15 **B**	16 **C**	17 **D**	18 **A**	19 **A**	20 **C**
21 **D**	22 **C**	23 **B**	24 **D**	25 **A**	26 **A**	27 **D**	28 **C**	29 **B**	30 **D**
31 **C**	32 **A**	33 **D**	34 **B**	35 **B**	36 **A**	37 **C**	38 **A**	39 **A**	40 **D**
41 **B**	42 **B**	43 **A**	44 **D**	45 **D**	46 **C**	47 **A**	48 **D**	49 **B**	50 **C**

A cor ao lado de cada letra é a da arma da banca, como na tabela anterior. Distribuição: A 13, B 13, C 12, D 12.

RESOLUÇÃO

Questão por questão

1 Hematologia · PTT com ADAMTS13 normal colhida depois de duas plasmaféreses: atividade falsamente preservada pelo plasma infundido, manter a plasmaférese e não trocar por anti-C5

Cronologia **Gabarito A**

Mulher de 29 anos, sem comorbidades, em uso de anticoncepcional oral, apresentou há 4 dias cefaleia, febre baixa, petéquias e dois episódios de afasia transitória. No hospital de origem: Hb 7,0 g/dL, plaquetas 8.000/mm³, esquizócitos 7%, LDH 1.480 U/L, haptoglobina indetectável, Coombs direto negativo, creatinina 1,3 mg/dL, TP e fibrinogênio normais. Recebeu metilprednisolona e duas sessões de plasmaférese antes da transferência, sem amostra guardada. Na chegada: PA 152 × 94 mmHg, Glasgow 15, sem déficit focal, plaquetas 19.000/mm³, LDH 1.120 U/L, creatinina 1,2 mg/dL, sem diarreia nas últimas semanas e pesquisa de toxina Shiga negativa. A atividade de ADAMTS13, colhida no novo hospital após a segunda sessão de plasmaférese, é de 46%. O nefrologista sugere suspender a plasmaférese e iniciar eculizumabe pela pressão alta. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

colhida no novo hospital após a segunda sessão de plasmaférese

Resolução. ADAMTS13 acima de 10% afasta PTT e, numa microangiopatia que não responde, aponta SHU atípica mediada por complemento, a ser tratada com anti-C5; a hipertensão reforça a ideia. Só que a regra vale para amostra colhida antes da plasmaférese: depois de duas sessões, a paciente recebeu litros de plasma normal com ADAMTS13 funcionante, e a atividade medida reflete o plasma do doador, e não a dela. O quadro é de PTT: plaquetas abaixo de 20.000, sintomas neurológicos e creatinina pouco alterada (abaixo de 2 mg/dL), o que dá escore PLASMIC alto, e a SHU atípica costuma vir com lesão renal grave. As plaquetas já subiram e a LDH caiu, sinais de resposta à plasmaférese. A conduta é manter a plasmaférese diária com corticoide, considerar rituximabe e caplacizumabe, dosar o anticorpo anti-ADAMTS13 (que persiste após a troca) e só reconsiderar o diagnóstico se não houver resposta. Transfundir plaquetas na PTT pode precipitar trombose e só se faz em sangramento grave.

A) Manter plasmaférese diária e corticoide CORRETA

Correta. A ADAMTS13 colhida após plasmaférese é falsamente normal; quadro neurológico, creatinina baixa e plaquetas em resposta sustentam PTT e a manutenção da troca plasmática.

B) Suspender a plasmaférese e iniciar eculizumabe ARMADILHA

Errada. É a armadilha do exame tranquilizador: seria a conduta na SHU atípica com ADAMTS13 acima de 10% em amostra pré-plasmaférese e lesão renal importante, ausentes aqui.

C) Suspender a plasmaférese e transfundir plaquetas

Errada. Transfusão de plaquetas na PTT pode alimentar a formação de microtrombos e se reserva a sangramento grave ou procedimento de alto risco.

D) Suspender a plasmaférese e iniciar hemodiálise

Errada. Seria pensada na SHU com insuficiência renal oligúrica; aqui a creatinina é de 1,2 mg/dL, e suspender a plasmaférese interrompe o tratamento da PTT.

Para levar. ADAMTS13 só vale se colhida antes da plasmaférese; atividade normal depois da troca plasmática não afasta PTT, e o quadro clínico (PLASMIC, rim pouco acometido, resposta das plaquetas) decide manter o tratamento.

Zheng XL et al. ISTH guidelines for the diagnosis and treatment of thrombotic thrombocytopenic purpura. J Thromb Haemost 2020; Bendapudi PK et al. PLASMIC score. Lancet Haematol 2017.

Revisa: S1 q62 (SHU atípica x PTT pela ADAMTS13 colhida antes da plasmaférese): o inverso, a amostra colhida depois da troca

---

2

Endocrinologia · Nódulo tireoidiano sólido isoecoico de 1,2 cm, de margens lisas, com irmã com carcinoma papilífero e tireoglobulina alta: TI-RADS 3 abaixo do limiar, sem punção

Limiar **Gabarito B**

Mulher de 48 anos, assintomática, faz ultrassonografia de tireoide solicitada em check-up depois que a irmã teve carcinoma papilífero aos 52 anos. Nega irradiação cervical na infância e outros casos de câncer de tireoide na família. Exame cervical sem nódulos ou linfonodos palpáveis. TSH 1,9 mUI/L. A ultrassonografia mostra nódulo único no lobo direito, de 1,2 × 1,0 x 0,9 cm, sólido, isoecoico, mais largo que alto, de margens lisas, sem focos ecogênicos, e nenhum linfonodo cervical suspeito. Por iniciativa própria, um clínico já havia dosado a tireoglobulina sérica: 96 ng/mL (até 55). A paciente está ansiosa e pede que o nódulo seja retirado. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

de 1,2 × 1,0 x 0,9 cm

Resolução. A irmã com carcinoma papilífero, a tireoglobulina alta e a ansiedade da paciente empurram para a punção. A decisão, porém, vem da soma das características ultrassonográficas e do tamanho. No ACR TI-RADS, sólido (2 pontos) e isoecoico (1 ponto), sem nenhum outro achado suspeito, somam 3 pontos (TR3), que só pede punção a partir de 2,5 cm e seguimento a partir de 1,5 cm; pela ATA, é nódulo de baixa suspeita, com punção a partir de 1,5 cm. Com 1,2 cm, nenhum dos sistemas indica punção. A tireoglobulina sérica não diferencia nódulo benigno de maligno e não deve ser dosada na investigação de nódulo, e a cintilografia só entra com TSH baixo. Um parente de primeiro grau com carcinoma papilífero não muda o limiar de punção de um nódulo de baixa suspeita.

A) Cintilografia de tireoide com iodo-123
Errada. A cintilografia identifica nódulo autônomo e só se indica com TSH baixo; aqui o TSH é normal.

B) Seguimento ultrassonográfico, sem punção CORRETA
Correta. Sólido isoecoico sem outros achados (TR3, baixa suspeita) com 1,2 cm fica abaixo do limiar de punção; o seguimento é por ultrassonografia.

C) Punção aspirativa com agulha fina ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a punção seria indicada a partir de 1,5 cm neste padrão de baixa suspeita, ou a partir de 1 cm se houvesse hipoecogenicidade acentuada, margem irregular, microcalcificações ou forma mais alta que larga.

D) Lobectomia diagnóstica direita
Errada. Cirurgia diagnóstica seria para citologia indeterminada com suspeita clínica; aqui não há sequer indicação de punção.

Para levar. Nódulo tireoidiano se decide pelo padrão ultrassonográfico e pelo tamanho: baixa suspeita só se punciona a partir de 1,5 cm pela ATA (2,5 cm no TI-RADS 3 do ACR), história de um parente de primeiro grau não muda o corte, e tireoglobulina sérica não tem papel na avaliação do nódulo.

Tessler FN et al. ACR Thyroid Imaging, Reporting and Data System (TI-RADS). J Am Coll Radiol 2017; Haugen BR et al. 2015 American Thyroid Association Management Guidelines for Adult Patients with Thyroid Nodules and Differentiated Thyroid Cancer. Thyroid 2016.

Revisa: UERJ recorrente: TI-RADS e indicação de punção; história familiar e tireoglobulina como distratores

---

3

Neurologia · Guillain-Barré no 4º dia com líquor sem dissociação e condução ainda normal: imunoglobulina já, sem esperar os exames positivarem

Cronologia **Gabarito C**

Homem de 34 anos procura o pronto-socorro com 4 dias de parestesias nos pés e nas mãos e fraqueza ascendente; hoje precisa de apoio para andar 5 metros. Teve diarreia há 2 semanas, resolvida sem tratamento. Sem febre, sem alteração esfincteriana, sem nível sensitivo. FC 112 bpm, PA oscilando entre 168/98 e 104/60 mmHg, FR 18 irpm, SpO2 97% em ar ambiente. Força grau 3 em membros inferiores e grau 4 em superiores, proximal e distal, arreflexia global, vibração reduzida nos pés. Capacidade vital forçada de 32 mL/kg. Líquor no 4º dia: 3 células/mm³, proteína 41 mg/dL (referência até 45), glicose normal. Eletroneuromiografia: ondas F com latência prolongada, velocidades de condução motora ainda normais. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

Líquor no 4º dia

Resolução. Líquor sem dissociação proteinocitológica e condução motora normal parecem não confirmar Guillain-Barré, e esperar uma semana para repetir os exames soa prudente. Mas a proteína do líquor só sobe a partir do fim da primeira semana, e na primeira semana até metade dos pacientes tem proteína normal; a ENMG precoce também pode mostrar apenas ondas F alteradas. O diagnóstico é clínico: fraqueza ascendente simétrica, arreflexia, diarreia prévia e disautonomia. O paciente já não anda sem apoio, o que indica tratamento imediato com imunoglobulina ou plasmaférese, que funcionam nas primeiras 2 semanas. A capacidade vital de 32 mL/kg não indica intubação agora, mas a disautonomia e a progressão pedem monitorização em terapia intensiva.

A) Repetir líquor e ENMG em 7 dias ARMADILHA

Errada. É a armadilha do exame precoce: líquor e ENMG normais na primeira semana não afastam a doença, e esperar perde a janela do tratamento.

B) Metilprednisolona IV em pulso

Errada. Corticoide não melhora o desfecho na síndrome de Guillain-Barré; seria uma conduta para polirradiculoneuropatia crônica.

C) Imunoglobulina IV, 2 g/kg em 5 dias CORRETA

Correta. Quadro clínico compatível, incapacidade de andar sem apoio e menos de 2 semanas de evolução indicam imunoglobulina já.

D) Intubação orotraqueal eletiva agora

Errada. Intubação eletiva se indica com capacidade vital abaixo de 20 mL/kg ou sinais de falência; aqui está em 32 mL/kg, e o que cabe é vigilância seriada.

Para levar. Na primeira semana do Guillain-Barré, líquor e ENMG podem ser normais; quem não anda sem apoio recebe imunoglobulina ou plasmaférese sem esperar os exames.

van Doorn PA et al. EAN/PNS Guideline on diagnosis and treatment of Guillain-Barré syndrome, Eur J Neurol 2023; Leonhard SE et al. Diagnosis and management of Guillain-Barré syndrome in ten steps, Nat Rev Neurol 2019.

Revisa: UERJ recorrente: Guillain-Barré; o líquor normal precoce como exame tranquilizador que atrasa o tratamento

---

4

Oncologia · Dor descontrolada por doses perdidas no paciente que deixou de engolir: morfina subcutânea na metade da dose oral, e não iniciar fentanil transdérmico agora

Qualificador **Gabarito D**

Homem de 59 anos, com carcinoma epidermoide de orofaringe recidivado e metástases ósseas, em cuidados paliativos domiciliares, vinha usando morfina de liberação imediata 20 mg por via oral de 4 em 4 horas, com dor controlada (2 em 10) e no máximo um resgate por dia nas últimas 2 semanas. Desde ontem, com piora da mucosite e da massa cervical, não consegue engolir nem líquidos e perdeu as três últimas doses. Chega à emergência com dor 8 em 10, inquieto, lúcido. PA 150/90 mmHg, FC 108 bpm, FR 20 irpm, SatO2 96%, mucosas pouco secas. Creatinina 0,8 mg/dL, sódio 141 mEq/L. A família traz um adesivo de fentanil 50 mcg/h prescrito por outro serviço, ainda não usado, e há acesso subcutâneo disponível. A conduta analgésica de manutenção mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

perdeu as três últimas doses

Resolução. O adesivo de fentanil já prescrito é praticamente equianalgésico aos 120 mg diários de morfina oral e resolve a falta da via oral, por isso atrai. Mas a dor não está estável: ele perdeu as três últimas doses e está com dor 8 em 10, e o fentanil transdérmico leva de 12 a 24 horas para atingir nível sérico, não se titula com rapidez e não é para dor descontrolada. A via certa agora é a subcutânea, que exige conversão: a morfina parenteral tem cerca do dobro da potência da oral, e os 120 mg orais por dia viram 60 mg subcutâneos, ou 10 mg de 4 em 4 horas, com resgate de 5 a 10 mg (10% a 15% da dose diária) e um resgate já na chegada. Repetir os 20 mg por via subcutânea dobraria a dose efetiva, e o tramadol tem teto e é mais fraco que o opioide que ele já usava. O adesivo pode entrar depois, com a dor controlada e estável.

A) Fentanil transdérmico 50 mcg/h isoladamente ARMADILHA
Errada. É a armadilha do adesivo pronto; seria uma troca razoável com dor estável, mas a latência de 12 a 24 horas deixa descoberta a dor descontrolada de agora.

B) Morfina 20 mg subcutânea de 4 em 4 horas
Errada. Repete a dose oral pela via subcutânea sem conversão, e a morfina parenteral tem cerca do dobro da potência: risco de sedação e depressão respiratória.

C) Tramadol 100 mg intravenoso de 6 em 6 horas
Errada. Seria opção para dor moderada em quem não usa opioide forte; aqui é um retrocesso na escada, com efeito teto.

D) Morfina 10 mg subcutânea de 4 em 4 horas CORRETA
Correta. Metade da dose oral diária por via subcutânea (60 mg/dia, 10 mg de 4 em 4 horas), com resgates, controla a dor e permite titular.

Para levar. Perdeu a via oral com dor descontrolada: morfina subcutânea na metade da dose oral diária, em horário fixo e com resgate de 10% a 15%; o fentanil transdérmico é para dor já estável, pela latência de 12 a 24 horas.

Academia Nacional de Cuidados Paliativos, Manual de Cuidados Paliativos, 3ª ed. (2021); ESMO Clinical Practice Guidelines, Management of cancer pain in adult patients (2018); NCCN Adult Cancer Pain (2025).

Revisa: S4 q24: escolha e via do opioide no paciente paliativo (antes o fentanil na DRC, agora o fentanil transdérmico que não serve para dor descontrolada)

---

5 Nefrologia · Nefropatia membranosa anti-PLA2R negativa com IgG1 e IgG2 no tabagista que perdeu peso: rastrear neoplasia antes de imunossuprimir

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Homem de 66 anos, tabagista de 50 maços-ano, apresenta edema de membros inferiores há 2 meses. É hipertenso controlado com hidroclorotiazida e perdeu 4 kg no período, que atribui à dieta. PA 134 × 82 mmHg, edema 3+/4+ até a raiz das coxas. Albumina 2,1 g/dL, colesterol total 340 mg/dL, proteinúria de 24 horas de 7,8 g, creatinina 1,1 mg/dL, sedimento sem hematúria dismórfica. FAN, anti-HCV, HBsAg e VDRL negativos; C3 e C4 normais; eletroforese e imunofixação de proteínas sem componente monoclonal. Anti-PLA2R sérico negativo. Biópsia renal: espessamento difuso da membrana basal com espículas e depósitos subepiteliais granulares de IgG, com predomínio de IgG1 e IgG2, IgG4 fraca, PLA2R negativo no tecido e mais de 8 células inflamatórias por glomérulo. O laudo conclui por nefropatia membranosa. O próximo passo mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

predomínio de IgG1 e IgG2, IgG4 fraca, PLA2R negativo no tecido

Resolução. O laudo de nefropatia membranosa com proteinúria de 7,8 g e albumina de 2,1 g/dL leva direto ao tratamento da forma primária, e o rituximabe é a primeira escolha atual nela. Mas a primária é uma doença por autoanticorpo IgG4, em geral contra PLA2R; aqui o anticorpo é negativo no soro e no tecido, a subclasse dominante é IgG1 e IgG2 e há infiltrado inflamatório glomerular, todos marcadores de membranosa secundária. Num homem de 66 anos, tabagista pesado e com perda de peso, a causa a buscar é neoplasia sólida (pulmão, cólon, próstata, estômago), e as causas infecciosas, lúpicas e monoclonais já foram afastadas. Imunossuprimir antes disso trata o epifenômeno e atrasa o diagnóstico de um câncer cuja ressecção pode remitir a proteinúria. Bloqueio do SRAA e anticoagulação conforme a albumina seguem indicados enquanto se investiga.

A) Novo anti-PLA2R sérico em 6 meses
Errada. Repetir o anti-PLA2R serve para monitorar a forma primária positiva; aqui o tecido já é negativo, e esperar 6 meses atrasa o diagnóstico.

B) Rastreio de neoplasia com TC de tórax CORRETA
Correta. Membranosa PLA2R negativa no tecido, com IgG1 e IgG2 e inflamação glomerular, em tabagista idoso que emagreceu, pede rastreio de neoplasia sólida antes de imunossuprimir.

C) Ciclosporina com corticoide em dose baixa
Errada. Inibidor de calcineurina é alternativa na membranosa primária; não se aplica antes de excluir a causa secundária sugerida pela biópsia.

D) Rituximabe com bloqueio do SRAA ARMADILHA

Errada. É a armadilha do laudo: rituximabe é o tratamento da membranosa primária anti-PLA2R positiva, mas aqui as subclasses IgG1 e IgG2 e o PLA2R negativo apontam forma secundária.

Para levar. Membranosa primária é IgG4 e PLA2R positiva; PLA2R negativa no tecido, IgG1 e IgG2 dominantes e células inflamatórias no glomérulo apontam causa secundária, e no idoso tabagista a primeira busca é neoplasia.

KDIGO 2021 Clinical Practice Guideline for the Management of Glomerular Diseases; Leeaphorn N et al. Prevalence of cancer in membranous nephropathy: a systematic review and meta-analysis. Am J Nephrol 2014.

Revisa: UERJ recorrente: membranosa e anti-PLA2R, agora pelo outro lado (a negativa que muda a conduta) + S4 q66 (rótulo da biópsia)

6

Pneumologia · Asma sem tratamento com sintomas diários, despertares semanais e VEF1 baixo: MART em dose média já no início (GINA)

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Mulher de 27 anos, com asma desde a infância e rinite alérgica, está sem tratamento de manutenção há 3 anos e usa salbutamol spray quase todos os dias. Refere sintomas diários e despertares noturnos por tosse e chiado 2 a 3 vezes por semana há 4 meses. Nunca foi internada, não procurou emergência no último ano e não usou corticoide oral. Prefere "o mínimo de remédio possível" e diz que se acostumou com o chiado. Não fuma, não usa betabloqueador nem anti-inflamatório. Hoje, em consulta ambulatorial agendada, está sem desconforto, FR 16 irpm, SpO2 97%, sibilos expiratórios esparsos. Espirometria: VEF1 de 58% do previsto, VEF1/CVF 0,62, com aumento de 420 mL (18%) após broncodilatador. Eosinófilos 410/mm³, IgE total 380 UI/mL. Técnica inalatória adequada, verificada na consulta. O tratamento inicial mais adequado é:

> O DADO QUE DECIDE
>
> *VEF1 de 58% do previsto*

Resolução. A ausência de internação, de idas à emergência e de corticoide oral, e a preferência dela por pouco remédio, são verdadeiras e levam ao degrau 3 (dose baixa de budesonida-formoterol em manutenção e resgate), que é o início para quem tem sintomas na maioria dos dias ou desperta uma vez por semana ou mais. O que eleva o degrau é a soma, prevista na GINA, de sintomas diários, despertares semanais e função pulmonar baixa: VEF1 de 58% do previsto. Essa apresentação já começa no degrau 4, com budesonida-formoterol em dose média como manutenção e resgate (podendo associar um curso curto de corticoide oral se muito descontrolada). Eosinofilia e IgE alta não indicam biológico no início: biológico é para asma grave que persiste no degrau 5 com boa adesão e técnica. Corticoide inalatório com salbutamol de resgate é a via alternativa, menos protetora contra exacerbações que a terapia de manutenção e resgate com formoterol.

A) Budesonida-formoterol apenas quando necessário

Errada. Budesonida-formoterol só quando necessário é o início para sintomas menos de 4 a 5 dias por semana, sem despertares semanais e com função normal.

B) Budesonida-formoterol dose baixa, manutenção e resgate ARMADILHA

Errada. É a armadilha: seria o início para sintomas na maioria dos dias ou despertar semanal; a função pulmonar baixa (VEF1 de 58%) somada aos sintomas diários leva ao degrau 4.

C) Budesonida-formoterol dose média, manutenção e resgate CORRETA

Correta. Sintomas diários, despertares semanais e VEF1 de 58% do previsto: degrau 4 da GINA, dose média de budesonida-formoterol em manutenção e resgate.

D) Corticoide inalatório dose baixa e salbutamol no resgate

Errada. É o degrau 2 da via alternativa, insuficiente para esta gravidade e inferior à terapia de manutenção e resgate na prevenção de exacerbações.

Para levar. Pela GINA, a asma que se apresenta com sintomas diários, despertar noturno semanal e função pulmonar baixa começa no degrau 4 (dose média de budesonida-formoterol em manutenção e resgate), e não no degrau 3.

Global Initiative for Asthma (GINA) 2024/2025, Box de tratamento inicial em adultos e adolescentes; Recomendações SBPT para o manejo da asma (2020).

Revisa: UERJ recorrente: degraus da GINA e MART; cruza com S2 q34 (asma: a gravidade é que decide, não o rótulo que o caso oferece)

7

Reumatologia · Dacrioadenite bilateral com plasmócitos IgG4 positivos e IgG4 sérica alta, mas com necrose geográfica e microabscessos: granulomatose com poliangeíte

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Homem de 49 anos apresenta há 6 meses aumento indolor e bilateral das glândulas lacrimais, com proptose leve à esquerda. Tem rinossinusite crônica com crostas e epistaxe ocasional, tratada com três cursos de antibiótico sem melhora. Nega asma, perda de peso ou xerostomia. PA 124 × 80 mmHg, sem linfonodomegalia, sem aumento de submandibulares ou parótidas. VHS 62 mm/h, PCR 38 mg/L, eosinófilos 600/mm³, creatinina 0,9 mg/dL, urina tipo 1 normal. IgG4 sérica de 168 mg/dL (referência: até 135). ANCA por imunofluorescência não reagente. Biópsia da glândula lacrimal: infiltrado linfoplasmocitário denso com 45 plasmócitos IgG4 positivos por campo de grande aumento e razão IgG4/IgG de 30%, com áreas de necrose geográfica, microabscessos neutrofílicos e células gigantes multinucleadas dispersas, sem flebite obliterante. O diagnóstico mais provável é:

> O DADO QUE DECIDE
>
> *áreas de necrose geográfica, microabscessos neutrofílicos e células gigantes multinucleadas dispersas*

Resolução. Dacrioadenite bilateral, IgG4 sérica alta e muitos plasmócitos IgG4 positivos parecem fechar doença relacionada à IgG4. Mas plasmócitos IgG4 positivos aparecem em vários infiltrados inflamatórios crônicos, e a IgG4 sérica discretamente alta é inespecífica. A histologia da doença por IgG4 é fibrose estoriforme e flebite obliterante, sem necrose; necrose geográfica, microabscessos neutrofílicos e granulomas são critério de exclusão no sistema ACR/EULAR de 2019 e apontam granulomatose com poliangeíte. A rinossinusite crostosa com epistaxe completa o quadro, e o ANCA negativo não afasta: a forma localizada de cabeça e pescoço é ANCA negativa em boa parte dos casos. A razão IgG4/IgG de 30% também fica abaixo dos 40% esperados na doença por IgG4.

A) Doença relacionada à IgG4 ARMADILHA

Errada. É a armadilha da contagem de plasmócitos IgG4 positivos; necrose, microabscessos e granulomas excluem a doença por IgG4, e falta a fibrose estoriforme com flebite obliterante.

B) Granulomatose com poliangeíte CORRETA

Correta. Necrose geográfica com microabscessos neutrofílicos e células gigantes, com rinossinusite crostosa, é granulomatose com poliangeíte, e a forma localizada é com frequência ANCA negativa.

C) Sarcoidose com acometimento orbitário

Errada. Seria considerada com granulomas não necrosantes bem formados; necrose geográfica e microabscessos falam contra.

D) Linfoma MALT de anexos oculares

Errada. Seria a hipótese com infiltrado linfoide monomórfico e clonalidade B; o infiltrado aqui é misto, com necrose e neutrófilos.

Para levar. Plasmócitos IgG4 positivos não bastam: a doença por IgG4 se confirma pela fibrose estoriforme e flebite obliterante, e necrose, microabscessos ou granulomas a excluem e apontam granulomatose com poliangeíte, mesmo com ANCA negativo.

Wallace ZS et al. 2019 ACR/EULAR classification criteria for IgG4-related disease; Deshpande V et al. Consensus statement on the pathology of IgG4-related disease, Mod Pathol 2012; Robson JC et al. 2022 ACR/EULAR classification criteria for granulomatosis with polyangiitis.

Revisa: S2 q31: a histologia da doença por IgG4, agora pelo lado dos critérios de exclusão; o rótulo do anticorpo (IgG4 positivo) é a arma

---

8

Cardiologia · Supradesnivelamento de ST inferior com assimetria de pressão entre os braços: dissecção de aorta tipo A, angiotomografia antes de qualquer reperfusão

Rótulo verdadeiro

Gabarito C

Homem de 58 anos, hipertenso com má adesão ao tratamento e tabagista, chega à emergência 1 hora e 40 minutos após dor torácica anterior de início súbito, já máxima desde o primeiro instante, que depois passou para a região interescapular. Está sudoreico e ansioso. Recebeu AAS 300 mg na triagem. Ao exame: PA de 172 × 96 mmHg no braço direito e de 118 × 74 mmHg no esquerdo, FC 98 bpm, SatO2 96%; pulso radial esquerdo mais fraco que o direito; sopro diastólico 2+/6 na borda esternal direita; sem déficit neurológico. ECG: supradesnivelamento do segmento ST de 2 mm em DII, DIII e aVF, com infradesnivelamento em DI e aVL. Troponina I 0,9 ng/mL (referência: até 0,04). Radiografia de tórax no leito: mediastino superior de 9 cm. O serviço de hemodinâmica está disponível e pode receber o paciente em 30 minutos. A conduta mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

PA de 172 × 96 mmHg no braço direito e de 118 × 74 mmHg no esquerdo

Resolução. O supradesnivelamento inferior com imagem em espelho e troponina alta é um infarto verdadeiro, e a hemodinâmica disponível em 30 minutos convida à angioplastia primária. Mas a dor súbita, máxima no início e migratória para o dorso, a diferença de mais de 20 mmHg na pressão sistólica entre os braços, o déficit de pulso, o sopro diastólico novo de insuficiência aórtica e o mediastino alargado tornam a dissecção de aorta tipo A muito provável (escore ADD-RS alto). O infarto inferior é a complicação: o flap da dissecção oclui o óstio da coronária direita, que é a mais acometida. Fibrinólise, heparina plena e a manipulação coronariana podem ser fatais nesse cenário. O passo é confirmar com angiotomografia de aorta (ou ecocardiograma transesofágico se instável), controlar dor, frequência e pressão com betabloqueador venoso e opioide, e encaminhar à cirurgia de emergência.

A) Heparina não fracionada em dose plena

Errada. Seria parte do tratamento da síndrome coronariana aguda ou do TEP; na dissecção, a anticoagulação plena é contraindicada.

B) Fibrinólise com tenecteplase

Errada. Seria a reperfusão do infarto com supra sem hemodinâmica em tempo hábil; na dissecção, a fibrinólise pode causar sangramento e tamponamento fatais.

C) Angiotomografia de aorta CORRETA

Correta. A diferença de pressão entre os braços com dor migratória e sopro diastólico exige confirmar a dissecção antes de qualquer antitrombótico.

D) Angioplastia primária da coronária direita ARMADILHA

Errada. Seria a conduta no infarto inferior isolado; aqui a assimetria de pressão, o déficit de pulso e o sopro diastólico indicam dissecção com oclusão do óstio coronariano.

Para levar. Supra de ST inferior com dor súbita migratória, assimetria de pressão ou de pulso e sopro diastólico novo é dissecção tipo A até prova em contrário: imagem da aorta antes de fibrinólise, heparina ou cateterismo.

2024 ESC Guidelines for the management of peripheral arterial and aortic diseases; 2022 ACC/AHA Guideline for the Diagnosis and Management of Aortic Disease; 2023 ESC Guidelines for the management of acute coronary syndromes.

Revisa: UERJ recorrente: dissecção de aorta e anisosfigmia + S1 q84 (diagnóstico vizinho que mata se tratado como o óbvio)

9

Infectologia · Paraparesia por HTLV-1 antes do pulso de corticoide com parasitológico negativo pelo método errado: ivermectina empírica

Negativo no meio | Gabarito A

Mulher de 49 anos, natural de Salvador, com paraparesia espástica progressiva há 3 anos, urgência miccional e lombalgia, teve diagnóstico de mielopatia associada ao HTLV-1, com Western blot reagente no soro e anticorpos no líquor. Nos últimos 4 meses a marcha piorou rapidamente, e o neurologista indicou pulso de metilprednisolona 1 g/dia por 3 dias seguido de prednisona oral. Nega diarreia, dor abdominal, prurido ou lesões de pele. Hemoglobina 12,8 g/dL, leucócitos 6.900/mm³ com eosinófilos 380/mm³, função renal e hepática normais. Três exames parasitológicos de fezes, pelo método de sedimentação espontânea (Hoffman), negativos. Sorologia para Strongyloides não disponível no serviço. Antes de iniciar o corticoide, a conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

pelo método de sedimentação espontânea (Hoffman), negativos

Resolução. Três parasitológicos negativos, sem sintomas digestivos e sem eosinofilia franca, parecem liberar o pulso. Mas o método de Hoffman detecta ovos e não é adequado para larvas de Strongyloides stercoralis, que exigem métodos de migração larval (Baermann-Moraes, Rugai) ou cultura em placa de ágar, e mesmo esses têm sensibilidade baixa com poucas amostras. Além disso, a coinfecção pelo HTLV-1 é o principal fator de risco para hiperinfecção, porque desvia a resposta para o perfil Th1 e reduz a eosinofilia e a IgE que controlariam o parasita; eosinófilos normais não tranquilizam. Corticoide em dose alta nessa paciente, de área endêmica, pode desencadear hiperinfecção com bacteremia por Gram-negativos e mortalidade alta. Sem sorologia disponível, a conduta é ivermectina empírica antes do pulso, e o corticoide segue indicado para a mielopatia em progressão.

A) Ivermectina empírica antes do corticoide CORRETA

Correta. Área endêmica, HTLV-1 e corticoide em dose alta com triagem inadequada pedem ivermectina empírica antes do pulso.

B) Pulso sem antiparasitário, com parasitológico de controle ARMADILHA

Errada. É a armadilha do parasitológico negativo: o método usado não detecta larvas, e a hiperinfecção pode começar dias após o pulso.

C) Albendazol por 3 dias antes do corticoide

Errada. Seria opção para ascaridíase e ancilostomíase; na estrongiloidíase é inferior à ivermectina e não é recomendado para prevenir hiperinfecção.

D) Contraindicar o corticoide pelo HTLV-1

Errada. O HTLV-1 não contraindica corticoide, que é o tratamento da mielopatia em fase de progressão rápida; basta tratar o Strongyloides antes.

Para levar. Antes de corticoide em dose alta em quem vem de área endêmica, especialmente com HTLV-1, trate Strongyloides empiricamente com ivermectina: parasitológico comum negativo não exclui.

Ministério da Saúde, Guia de Manejo Clínico da Infecção pelo HTLV (2022); Requena-Méndez A et al., Strongyloidiasis screening before immunosuppression, Clin Infect Dis (2017); CDC Strongyloidiasis Resources for Health Professionals (2024).

Revisa: S3 q1 (HTLV-1) cruzado com UERJ recorrente: corticoide muda o agente, estrongiloidíase com triagem negativa enganosa

---

10 Gastroenterologia e hepatologia · Líquido ascítico de punção traumática com 311 polimorfonucleares e 48.000 hemácias: sem PBE após a correção, sem antibiótico

Grade X / Y **Gabarito D**

Homem de 61 anos, com cirrose por hepatite C tratada com resposta virológica sustentada há 3 anos, Child-Pugh B8, é internado eletivamente para paracentese de alívio. Usa propranolol 40 mg e espironolactona 200 mg ao dia. Assintomático, sem dor abdominal, consciente e orientado, sem flapping; temperatura de 36,6 °C, PA 112/70 mmHg, FC 68 bpm. A punção diagnóstica foi difícil, exigiu três tentativas e o líquido saiu róseo e clareou no decorrer da drenagem. Líquido ascítico: leucócitos 820/mm³, 38% de polimorfonucleares (311/mm³), hemácias 48.000/mm³, proteína total 1,1 g/dL, albumina 0,6 g/dL, glicose 110 mg/dL, LDH 90 U/L; Gram sem bactérias, cultura semeada em frascos de hemocultura em andamento. Albumina sérica 2,9 g/dL, creatinina 1,0 mg/dL, bilirrubina total 2,1 mg/dL, sódio 136 mEq/L. A interpretação do líquido e a conduta mais adequada são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

hemácias 48.000/mm³

Resolução. Polimorfonucleares de 311/mm³ estão acima de 250, limiar de peritonite bacteriana espontânea, e o reflexo é antibiótico com albumina. Mas a punção foi traumática, e o sangue que contamina o líquido traz neutrófilos junto: desconta-se 1 polimorfonuclear para cada 250 hemácias. Com 48.000 hemácias, subtraem-se 192, e o valor corrigido é de cerca de 119/mm³, abaixo do limiar. Sem febre, dor, encefalopatia ou piora renal, não há indicação de antibiótico agora; aguarda-se a cultura, e se ela crescer bactéria com polimorfonucleares abaixo de 250 (bacterascite) repete-se a paracentese antes de decidir. Os critérios de Runyon (glicose baixa, LDH alta, proteína alta) estão ausentes, o que afasta peritonite secundária.

A) PBE / cefotaxima isolada

Errada. Seria o esquema para PBE sem creatinina acima de 1 mg/dL nem bilirrubina acima de 4 mg/dL, mas aqui não há PBE após corrigir pelas hemácias.

B) PBE / cefotaxima e albumina ARMADILHA

Errada. É a armadilha: seria a conduta com polimorfonucleares acima de 250 sem contaminação sanguínea; corrigido pelas 48.000 hemácias, o valor cai para cerca de 119.

C) Peritonite secundária / tomografia de abdome

Errada. Peritonite secundária se suspeita com dois critérios de Runyon (proteína acima de 1 g/dL, glicose abaixo de 50 mg/dL, LDH acima do limite sérico) ou germes múltiplos no Gram.

D) Sem PBE / aguardar a cultura CORRETA

Correta. Polimorfonucleares corrigidos de cerca de 119/mm³ em paciente assintomático: sem PBE, e a cultura define o passo seguinte.

Para levar. Em líquido ascítico hemorrágico, desconte 1 polimorfonuclear a cada 250 hemácias antes de aplicar o limiar de 250/mm³ para PBE.

AASLD Practice Guidance: Diagnosis, Evaluation, and Management of Ascites, SBP and Hepatorenal Syndrome, 2021; EASL Clinical Practice Guidelines on decompensated cirrhosis, 2018.

Revisa: UERJ recorrente: PBE no cirrótico, aqui pelo limiar corrigido em punção traumática

---

11

Hematologia · Linfoma MALT gástrico localizado, H. pylori positivo, com t(11;18): erradicar não basta, radioterapia gástrica sem esperar a resposta

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Homem de 57 anos, dispéptico há 6 meses, sem perda de peso, febre ou sudorese. Usa omeprazol há 2 meses, com melhora parcial. A endoscopia mostra área infiltrativa e erosada de 4 cm no corpo gástrico. A biópsia revela infiltrado de pequenas células de zona marginal com lesões linfoepiteliais, CD20 positivo, CD5, CD10 e ciclina D1 negativos, Ki-67 de 10%, sem lençóis de células grandes, e pesquisa de Helicobacter pylori positiva na histologia. A ecoendoscopia mostra infiltração até a submucosa, sem linfonodos perigástricos aumentados, e a TC de tórax, abdome e pelve é normal (estádio I). Hb 13,9 g/dL, LDH normal. A pesquisa por FISH detecta a translocação t(11;18)(q21;q21). A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

A pesquisa por FISH detecta a translocação t(11;18)(q21;q21)

Resolução. Linfoma MALT gástrico localizado com H. pylori positivo responde à erradicação em boa parte dos casos, e por isso a erradicação isolada, com endoscopias seriadas, é a conduta que se decora. A translocação t(11;18) muda a previsão: ela produz a fusão API2::MALT1, que ativa o NF-kappa-B de forma independente do estímulo antigênico, e esses linfomas quase nunca regridem com a retirada da bactéria (a invasão além da mucosa também prediz falha). O H. pylori ainda deve ser erradicado, mas o tratamento do linfoma localizado é a radioterapia gástrica em dose baixa, que cura a maioria, sem aguardar meses por uma resposta que não virá. R-CHOP seria a escolha para o linfoma difuso de grandes células B, afastado pela ausência de lençóis de células grandes e pelo Ki-67 baixo. A gastrectomia saiu do tratamento do linfoma gástrico, porque não supera a radioterapia e deixa sequela permanente.

A) Gastrectomia total com linfadenectomia

Errada. A cirurgia foi abandonada no linfoma gástrico por não superar radioterapia ou terapia sistêmica e por causar morbidade permanente.

B) Imunoquimioterapia com R-CHOP

Errada. Seria o tratamento do linfoma difuso de grandes células B gástrico ou do MALT avançado sintomático; aqui o estádio é I, o Ki-67 é baixo e não há células grandes.

C) Erradicação do H. pylori e radioterapia gástrica CORRETA

Correta. A bactéria deve ser erradicada, mas com t(11;18) a erradicação não controla o linfoma, e o estádio I se cura com radioterapia gástrica.

D) Erradicação do H. pylori isoladamente ARMADILHA

Errada. É a armadilha do H. pylori positivo: seria a conduta no MALT localizado sem t(11;18), mas a translocação torna o linfoma independente da bactéria.

Para levar. MALT gástrico localizado: H. pylori positivo sem t(11;18), erradicar e seguir; com t(11;18) ou H. pylori negativo, radioterapia gástrica, porque o linfoma não depende da bactéria.

Zucca E et al. Marginal zone lymphomas: ESMO Clinical Practice Guidelines 2020; NCCN Guidelines B-Cell Lymphomas 2025; V Consenso Brasileiro sobre Helicobacter pylori 2026.

Revisa: S1 q42 (DGCB gástrico x MALT): outro ângulo, o MALT localizado que não responde à erradicação pela t(11;18)

12

Endocrinologia · Hipercalcemia com PTH suprimido, PTHrP indetectável, 25-OH-vitamina D normal e calcitriol alto em paciente com linfoma e suplemento de colecalciferol: produção extrarrenal de calcitriol, glicocorticoide

Grade X / Y **Gabarito B**

Homem de 63 anos, em investigação de febre vespertina, sudorese noturna e perda de 8 kg há 3 meses, é internado por confusão e poliúria. Usa colecalciferol 7.000 UI por semana há 2 anos, prescrito por osteopenia. Esplenomegalia a 4 cm do rebordo costal; a tomografia mostra linfonodomegalias retroperitoneais de até 3 cm, sem lesões ósseas líticas. Cálcio total 13,4 mg/dL (8,5 a 10,5), albumina 3,6 g/dL, fósforo 4,3 mg/dL (2,5 a 4,5), creatinina 1,7 mg/dL, PTH 6 pg/mL (15 a 65), PTHrP indetectável, 25-hidroxivitamina D 42 ng/mL (30 a 60), 1,25-di-hidroxivitamina D 118 pg/mL (20 a 79), eletroforese de proteínas sem pico monoclonal, DHL 680 U/L. Além da hidratação venosa, o mecanismo da hipercalcemia e o tratamento específico são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

25-hidroxivitamina D 42 ng/mL (30 a 60)

Resolução. O suplemento de colecalciferol é verdadeiro e puxa para intoxicação por vitamina D, cuja solução seria suspendê-lo. Mas a intoxicação exógena eleva a 25-hidroxivitamina D, em geral acima de 150 ng/mL, e aqui ela está normal; o que está alto é a forma ativa, 1,25-di-hidroxivitamina D. Com PTH suprimido (a hipercalcemia não depende da paratireoide), PTHrP indetectável e sem lesões líticas nem pico monoclonal, o mecanismo é a hidroxilação extrarrenal da 25-hidroxivitamina D pela 1-alfa-hidroxilase dos macrófagos do tumor, sem o freio que existe no rim. Isso ocorre em linfomas, sobretudo de Hodgkin e alguns não Hodgkin, e em doenças granulomatosas, e o fósforo no limite superior é coerente com o aumento da absorção intestinal. O tratamento específico é o glicocorticoide, que inibe essa enzima nos macrófagos, junto com o tratamento do linfoma; o suplemento também deve ser suspenso, mas não resolve.

A) Intoxicação por vitamina D / suspender o colecalciferol ARMADILHA

Errada. É a armadilha do suplemento: a intoxicação por vitamina D eleva a 25-hidroxivitamina D, que aqui está normal.

B) Calcitriol extrarrenal / glicocorticoide CORRETA

Correta. PTH e PTHrP suprimidos, 25-hidroxivitamina D normal e calcitriol alto num linfoma indicam produção extrarrenal de calcitriol, que responde a glicocorticoide.

C) PTHrP tumoral / bisfosfonato venoso

Errada. Seria o mecanismo mais comum da hipercalcemia maligna, em tumores sólidos, com PTHrP elevado; aqui ele é indetectável.

D) Osteólise local / denosumabe

Errada. Seria o mecanismo no mieloma e nas metástases ósseas líticas; não há lesões líticas nem pico monoclonal.

Para levar. Hipercalcemia com PTH suprimido, PTHrP normal e 1,25-di-hidroxivitamina D alta com 25-hidroxivitamina D normal é produção extrarrenal de calcitriol (linfoma ou granuloma), e o tratamento específico é glicocorticoide.

El-Hajj Fuleihan G et al. Treatment of hypercalcemia of malignancy in adults: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2023.

Revisa: UERJ recorrente: hipercalcemia do linfoma por calcitriol; o suplemento de vitamina D como distrator verdadeiro

---

13 Neurologia · Piora de déficits antigos da esclerose múltipla com febre e infecção urinária: pseudossurto, trata-se a infecção sem pulsoterapia

Omissão **Gabarito A**

Mulher de 33 anos, com esclerose múltipla remitente-recorrente há 6 anos, em uso de natalizumabe com índice anti-JC negativo, procura o pronto-socorro por piora da fraqueza da perna esquerda e da visão do olho direito há 24 horas, déficits que tinham sobrado de surtos em 2021 e 2023. Refere ardor miccional e polaciúria há 3 dias e calafrios. Temperatura 38,7 °C, PA 112/70 mmHg, FC 104 bpm. Exame: força grau 3 na perna esquerda (era 4 no último retorno), acuidade visual de 20/100 à direita (era 20/40), com defeito pupilar aferente relativo já conhecido, sem déficit em território novo. Urina: piócitos incontáveis e nitrito positivo. Glicemia e eletrólitos normais. RM de crânio de 2 meses atrás sem lesões novas. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

déficits que tinham sobrado de surtos em 2021 e 2023

Resolução. Piora neurológica há 24 horas numa paciente com esclerose múltipla parece surto e leva à pulsoterapia. Mas surto exige sintoma novo ou piora com mais de 24 horas na ausência de febre ou infecção. Aqui a piora é dos mesmos déficits residuais de surtos antigos, sem território novo, e acompanha febre por infecção urinária: é pseudossurto, em que a temperatura alta bloqueia a condução em axônios já desmielinizados (fenômeno de Uhthoff). Trata-se a infecção e a febre, e o déficit volta ao basal em horas a dias; o corticoide em pulso, além de inútil, piora o controle da infecção. Se o déficit persistir após resolver a infecção, aí se reavalia surto com RM.

A) Tratar a infecção urinária e a febre CORRETA

Correta. Piora dos déficits residuais com febre e infecção é pseudossurto: tratar a infecção e baixar a temperatura.

B) Metilprednisolona 1 g/dia por 3 a 5 dias ARMADILHA

Errada. É a armadilha: pulsoterapia trata surto, que exige ausência de febre e infecção; aqui piora a infecção sem benefício neurológico.

C) Plasmaférese em 5 sessões

Errada. Plasmaférese é resgate de surto grave refratário ao corticoide, situação que não existe aqui.

D) Suspender natalizumabe e investigar LEMP

Errada. LEMP seria suspeita com déficit novo e progressivo em anti-JC positivo; o índice é negativo e os déficits são antigos.

Para levar. Piora de déficits antigos da esclerose múltipla junto com febre ou infecção é pseudossurto: trata-se a causa, sem pulsoterapia.

Thompson AJ et al. Diagnosis of multiple sclerosis: 2017 revisions of the McDonald criteria, Lancet Neurol 2018; Comitê Brasileiro de Tratamento e Pesquisa em Esclerose Múltipla (BCTRIMS), consenso de tratamento 2022.

Revisa: UERJ recorrente: esclerose múltipla; a resposta é o degrau mais simples quando a piora vem com febre

---

14 Cardiologia · Fibrilação atrial com estenose mitral reumática moderada a grave e escore zero: varfarina, e não DOAC nem ausência de anticoagulação

Limiar **Gabarito B**

Mulher de 34 anos, natural de Pernambuco, procura atendimento por palpitações e cansaço aos esforços há 3 semanas. Teve febre reumática aos 10 anos e usa penicilina benzatina irregularmente. Não tem hipertensão, diabetes, doença vascular ou insuficiência cardíaca diagnosticada; não fuma e usa DIU de cobre. Ao exame: PA 116 × 72 mmHg, FC 104 bpm, ritmo irregular, B1 hiperfonética, estalido de abertura e ruflar diastólico apical. ECG: fibrilação atrial com resposta ventricular de 108 bpm. O escore CHA2DS2-VA calculado na triagem é zero. Ecocardiograma: área valvar mitral de 1,3 cm² pela planimetria, gradiente médio de 9 mmHg, átrio esquerdo de 52 mm, sem trombo visível, PSAP de 44 mmHg, FE de 62%. Creatinina 0,6 mg/dL, hemograma normal. Foi iniciado metoprolol para controle da frequência. Quanto à prevenção de tromboembolismo, a conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

área valvar mitral de 1,3 cm² pela planimetria

Resolução. O escore CHA2DS2-VA zero, numa mulher jovem sem comorbidades, é verdadeiro e levaria a não anticoagular numa fibrilação atrial não valvar. Mas os escores não se aplicam à fibrilação atrial com estenose mitral moderada a grave, que já é de altíssimo risco embólico pelo átrio esquerdo grande e estase: a anticoagulação está indicada independentemente do escore. O limiar que define a categoria é a área valvar abaixo de 1,5 cm², e aqui ela é de 1,3 cm², de origem reumática. Nesses pacientes, os anticoagulantes orais diretos foram excluídos dos grandes ensaios e, no INVICTUS, a rivaroxabana foi inferior à varfarina em eventos e mortalidade; o anticoagulante é a varfarina com RNI entre 2 e 3. Com área valvar nessa faixa e sintomas, ela deve ser avaliada também para valvoplastia mitral por balão.

A) Apixabana 5 mg de 12 em 12 horas

Errada. Apixabana seria adequada na fibrilação atrial não valvar com escore de pelo menos 2, ou com estenose mitral leve; não com área de 1,3 cm².

B) Varfarina com RNI alvo entre 2 e 3 CORRETA

Correta. Fibrilação atrial com estenose mitral reumática moderada a grave exige varfarina, qualquer que seja o escore.

C) Nenhuma anticoagulação, pelo escore zero ARMADILHA

Errada. É a armadilha do escore da triagem; o CHA2DS2-VA não vale para estenose mitral moderada a grave.

D) Dabigatrana 150 mg de 12 em 12 horas

Errada. Dabigatrana é contraindicada na estenose mitral moderada a grave, e também em prótese mecânica; serviria na fibrilação atrial não valvar.

Para levar. Fibrilação atrial com estenose mitral reumática de área abaixo de 1,5 cm² ou prótese mecânica: varfarina com RNI 2 a 3, sem calcular escore e sem anticoagulante oral direto.

2024 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation; Connolly SJ et al. Rivaroxaban in Rheumatic Heart Disease-Associated Atrial Fibrillation (INVICTUS). N Engl J Med 2022; 2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease; Diretriz Brasileira de Valvopatias, SBC 2020.

Revisa: UERJ recorrente: anticoagulação na FA + S4 q56 (o critério que define o anticoagulante)

---

15 Nefrologia · Creatinina subindo a partir da segunda semana após cateterismo, com livedo e eosinofilia: doença ateroembólica, e não lesão por contraste

Cronologia **Gabarito B**

Homem de 70 anos, hipertenso, diabético e tabagista, com creatinina basal de 1,3 mg/dL, foi submetido a cateterismo cardíaco por via femoral com angioplastia da artéria descendente anterior, recebendo 180 mL de contraste iodado, com hidratação venosa antes e depois. No segundo dia a creatinina era de 1,4 mg/dL e recebeu alta com AAS, clopidogrel e atorvastatina. Retorna no 21º dia com creatinina de 3,8 mg/dL, em ascensão progressiva desde a segunda semana segundo exames do posto, PA de 178 × 100 mmHg (antes controlada) e dor no hálux esquerdo. Ao exame, livedo reticular em coxas e pododáctilos arroxeados, com pulsos pediosos palpáveis. Eosinófilos 980/mm³, C3 72 mg/dL (90 a 180). Urina com proteína em traços, sem hemácias e sem leucocitúria. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

em ascensão progressiva desde a segunda semana

Resolução. O volume de contraste alto e o paciente diabético com doença renal leve tornam a lesão por contraste a explicação mais lembrada. Mas ela segue uma cronologia própria: a creatinina sobe em 24 a 72 horas, faz pico em 3 a 5 dias e volta ao basal em 1 a 2 semanas; aqui a creatinina estava estável no segundo dia e começou a subir na segunda semana, de forma progressiva. Lesão subaguda após manipulação da aorta, com livedo reticular, dedos arroxeados com pulsos palpáveis, hipertensão nova, eosinofilia e consumo de complemento é doença ateroembólica por cristais de colesterol. A eosinofilia e o complemento baixo poderiam sugerir nefrite intersticial, mas o sedimento sem leucocitúria e as lesões cutâneas isquêmicas distais apontam embolia. O tratamento é de suporte, com estatina, controle pressórico e evitar novas manipulações vasculares.

A) Trombose aguda da artéria renal

Errada. A trombose arterial renal causa perda abrupta de função com dor lombar e LDH alta, e não ascensão gradual com lesões cutâneas distais.

B) Doença renal ateroembólica CORRETA

Correta. Lesão renal que progride a partir da segunda semana após cateterismo, com livedo, dedos arroxeados com pulsos presentes, eosinofilia e C3 baixo, é ateroembolia.

C) Nefrite intersticial aguda pelo clopidogrel

Errada. Nefrite intersticial explicaria a eosinofilia, mas daria leucocitúria e não causaria livedo nem isquemia digital com pulsos palpáveis.

D) Lesão renal induzida por contraste ARMADILHA

Errada. É a armadilha do contraste: a lesão por contraste surge em 24 a 72 horas e melhora em até 2 semanas; aqui a creatinina era estável no segundo dia e subiu depois.

Para levar. Após cateterismo, creatinina que sobe em dias e volta é contraste; que sobe a partir da segunda semana, com livedo, eosinofilia e complemento baixo, é ateroembolia.

KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline for Acute Kidney Injury; Scolari F, Ravani P. Atheroembolic renal disease. Lancet 2010.

Revisa: UERJ recorrente: IRA após contraste pela cronologia + S2 q80 (contraste)

16

Reumatologia · Pancitopenia com mucosite em idosa com metotrexato, doença renal e sulfametoxazol-trimetoprima recente: ácido folínico, e não ácido fólico

Qualificador **Gabarito C**

Mulher de 72 anos, com artrite reumatoide em uso de metotrexato 20 mg/semana há 3 anos e ácido fólico 5 mg/semana, tem doença renal crônica com creatinina de 1,9 mg/dL (TFGe de 26 mL/min/1,73 m²), sem ajuste recente da dose. Há 10 dias foi tratada para cistite com sulfametoxazol-trimetoprima por 7 dias, prescrito no pronto-atendimento. Há 4 dias surgiram úlceras orais dolorosas e, hoje, febre de 38,4 °C. PA 108 × 64 mmHg, FC 104 bpm, mucosite extensa, sem foco infeccioso evidente. Hb 8,9 g/dL, VCM 104 fL, leucócitos 1.100/mm³ com 300 neutrófilos, plaquetas 31.000/mm³, ALT 88 U/L. Já se suspendeu o metotrexato, colheram-se culturas e iniciou-se cefepime. A medida específica mais importante neste momento é:

> O DADO QUE DECIDE
>
> *Há 10 dias foi tratada para cistite com sulfametoxazol-trimetoprima por 7 dias*

Resolução. Quem já usa ácido fólico com metotrexato tende a só aumentar a dose do mesmo ácido fólico. A toxicidade aqui é grave: pancitopenia com neutropenia febril e mucosite, precipitada pela soma de função renal reduzida (o metotrexato é eliminado pelo rim) com a trimetoprima, que também inibe a di-hidrofolato redutase e reduz a secreção tubular do metotrexato. O ácido fólico precisa da di-hidrofolato redutase para virar folato ativo, e essa enzima está bloqueada; o ácido folínico (leucovorina) já é folato reduzido e contorna o bloqueio, e por isso é o antídoto. O filgrastim pode ser associado na neutropenia grave, mas não é a medida específica. A hemodiálise convencional remove pouco metotrexato; a glucarpidase fica para níveis altos após dose oncológica.

A) Ácido fólico 5 mg ao dia ARMADILHA

Errada. O ácido fólico depende da di-hidrofolato redutase, bloqueada pelo metotrexato e pela trimetoprima; serve para prevenir efeitos leves, não para resgatar toxicidade grave.

B) Filgrastim subcutâneo diário

Errada. Pode ser associado na neutropenia febril grave, mas é suporte e não reverte o bloqueio do folato.

C) Ácido folínico em dose alta CORRETA

Correta. A leucovorina é folato reduzido que contorna a enzima bloqueada e é o antídoto da toxicidade do metotrexato.

D) Hemodiálise convencional

Errada. A hemodiálise convencional remove pouco metotrexato; o recurso extracorpóreo fica para níveis muito altos após dose oncológica, com glucarpidase como alternativa.

Para levar. Toxicidade grave do metotrexato (pancitopenia, mucosite), sobretudo com doença renal e trimetoprima, se resgata com ácido folínico; o ácido fólico não funciona com a di-hidrofolato redutase bloqueada.

Fraenkel L et al. 2021 ACR Guideline for the Treatment of Rheumatoid Arthritis; Howard SC et al. Preventing and managing toxicities of high-dose methotrexate, Oncologist 2016; Mota LMH et al. Recomendações da SBR para o tratamento da artrite reumatoide, 2017.

Revisa: UERJ recorrente: drogas antirreumáticas e seus efeitos (interação do metotrexato com trimetoprima e o antídoto certo)

---

17 Infectologia · Dengue na defervescência com plaquetas abaixo de 20 mil e sem sangramento mucoso: hidratação oral, sem transfundir

Limiar **Gabarito D**

Mulher de 33 anos, professora, previamente hígida, está no 5º dia de dengue confirmada por NS1 reagente no 2º dia; a febre cedeu ontem. Relata cansaço e inapetência, mas aceita bem líquidos; nega dor abdominal, vômitos, tontura ao levantar e redução da diurese. Notou pontos vermelhos nas pernas, sem sangramento de mucosas, sem melena e sem fluxo menstrual aumentado. Ao exame, PA 112/72 mmHg deitada e 110/70 mmHg em pé, FC 84 bpm, enchimento capilar de 2 segundos, petéquias nos membros inferiores, prova do laço positiva, sem hepatomegalia e sem derrames. Hematócrito 41% (basal de 39% no 2º dia), plaquetas 14.000/mm³, albumina 3,8 g/dL. A família pede que se faça transfusão de plaquetas 'antes que sangre'. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

sem sangramento de mucosas

Resolução. Plaquetas abaixo de 20.000/mm³ lembram o limiar de transfusão profilática da plaquetopenia por falência medular, e a pressão da família reforça. Na dengue esse limiar não vale: a plaquetopenia é periférica, por consumo e destruição imune, se recupera em poucos dias, e a transfusão profilática não reduz sangramento grave nem mortalidade, além de expor a riscos e sobrecarga. A paciente tem petéquias e prova do laço positiva, sem sinais de alarme (sem dor abdominal, vômitos, hipotensão postural, sangramento mucoso ou aumento relevante do hematócrito), e por isso é grupo B: hidratação oral vigorosa, hemograma e reavaliação clínica diária até 48 horas após a defervescência, que é a fase crítica. Plaquetas só se transfundem com sangramento ativo relevante que persiste após corrigir volume e coagulação.

A) Transfusão profilática de plaquetas ARMADILHA

Errada. É a armadilha do número: o limiar de 20.000 vale para aplasia e quimioterapia, e não para a plaquetopenia periférica e transitória da dengue sem sangramento.

B) Internação com hidratação venosa

Errada. Seria a certa no grupo C, com sinal de alarme como dor abdominal, vômitos persistentes, hipotensão postural ou hematócrito subindo; nenhum está presente.

C) Prednisona para a plaquetopenia

Errada. Seria tratamento da trombocitopenia imune primária com sangramento; na dengue o corticoide não acelera a recuperação das plaquetas.

D) Hidratação oral e reavaliação diária CORRETA

Correta. Grupo B na fase crítica: hidratação oral, hemograma e reavaliação diária, sem transfusão.

Para levar. Na dengue, plaquetas baixas sem sangramento ativo não se transfundem, qualquer que seja o número: o que define a conduta são os sinais de alarme e o hematócrito.

Ministério da Saúde, Dengue: Diagnóstico e Manejo Clínico, Adulto e Criança, 6ª ed. (2024); OPAS, Diretrizes para o Diagnóstico Clínico e Tratamento de Dengue, Chikungunya e Zika (2022).

Revisa: UERJ recorrente: arboviroses, com o limiar de transfusão da falência medular aplicado no lugar errado

---

18

Pneumologia · TEP não provocado com investigação básica normal e história familiar de câncer: anticoagulação prolongada e sem rastreio extenso de neoplasia oculta

Grade X / Y **Gabarito A**

Homem de 56 anos, ex-tabagista (20 maços-ano, parou há 10 anos), recebeu diagnóstico de TEP segmentar bilateral há 5 dias, com PA normal, ventrículo direito normal ao ecocardiograma e troponina normal; está em rivaroxabana e assintomático. Nos 3 meses anteriores não fez cirurgia, não foi internado, não ficou imobilizado, não teve trauma nem viagem longa e não usa testosterona. Peso estável, sem sangramentos, sem alteração do hábito intestinal. A mãe teve câncer de mama aos 72 anos e o irmão, câncer de pâncreas aos 68; ele pergunta se não deveria "fazer uma tomografia do corpo todo". Exame físico completo, hemograma, cálcio, enzimas hepáticas, creatinina, urina tipo 1 e radiografia de tórax normais; PSA 1,2 ng/mL; colonoscopia de 3 anos atrás normal. Não tem antecedente de sangramento e o clearance de creatinina é de 92 mL/min. A duração da anticoagulação e a investigação de câncer oculto mais adequadas são, respectivamente:

> O DADO QUE DECIDE
>
> *não fez cirurgia, não foi internado, não ficou imobilizado, não teve trauma nem viagem longa e não usa testosterona*

Resolução. A história familiar de câncer e o pedido do paciente são verdadeiros e puxam para o rastreio extenso, com TC de abdome e pelve ou PET-CT. Nos ensaios em TEV não provocado (como o SOME, com TC de abdome e pelve), acrescentar imagem ao rastreio básico não aumentou a detecção relevante de câncer nem reduziu mortalidade; por isso se faz anamnese, exame físico, exames básicos, radiografia de tórax e os rastreios apropriados à idade e ao sexo, todos já feitos e normais. A duração é decidida pelo fator de risco: sem cirurgia, internação, imobilização, trauma ou hormônio, o TEP é não provocado, e o risco de recorrência após suspender passa de 10% no primeiro ano. Com baixo risco de sangramento, a anticoagulação é

prolongada sem data definida, reavaliada periodicamente, e não limitada a 3 meses. A história familiar de câncer não muda nenhuma das duas decisões.

A) Prolongada sem data / investigação básica já feita CORRETA
Correta. TEP sem fator provocador, risco de sangramento baixo: anticoagulação prolongada; investigação limitada, que já foi feita e é normal.

B) Três meses / investigação básica já feita
Errada. Três meses servem ao TEP provocado por fator transitório maior (cirurgia, imobilização); aqui não houve nenhum, e o risco de recorrência é alto.

C) Prolongada sem data / TC de abdome e pelve ARMADILHA
Errada. É a armadilha da história familiar: a duração está certa, mas a TC de abdome e pelve no TEV não provocado não melhorou a detecção nem a sobrevida (estudo SOME).

D) Três meses / PET-CT de corpo inteiro
Errada. Erra as duas: três meses é pouco para TEP não provocado, e PET-CT de rotina não tem benefício demonstrado na busca de câncer oculto.

Para levar. TEP não provocado com baixo risco de sangramento: anticoagulação prolongada sem data; câncer oculto se procura com anamnese, exame, exames básicos e rastreio de idade e sexo, sem TC de abdome nem PET de rotina.

ESC Guidelines on acute pulmonary embolism (2019); ASH Guidelines on treatment of VTE (2020); CHEST Guideline and Expert Panel Report on VTE (2021); Carrier M et al. SOME trial, N Engl J Med 2015.

Revisa: UERJ recorrente: TEP, duração da anticoagulação e câncer oculto; cruza com S2 q52 (grade de TEP)

19

Endocrinologia · Doença de Addison autoimune recém-diagnosticada com TSH de 8,9, T4 livre normal e anti-TPO negativo: repor glicocorticoide e repetir o TSH antes de qualquer levotiroxina

Omissão **Gabarito A**

Mulher de 34 anos, com vitiligo desde os 20 anos, procura atendimento por cansaço progressivo há 8 meses, perda de 6 kg, náuseas, desejo por sal e tontura ao levantar. Pele com hiperpigmentação nas pregas palmares e na gengiva. PA 92 × 60 mmHg deitada, caindo para 78 × 50 mmHg em pé, FC 104 bpm. Sódio 128 mEq/L, potássio 5,6 mEq/L, glicemia 74 mg/dL, cortisol às 8 horas 2,1 µg/dL, ACTH 410 pg/mL (até 46), anticorpo anti-21-hidroxilase positivo. TSH 8,9 mUI/L (0,4 a 4,5), T4 livre 1,0 ng/dL (0,9 a 1,8), anti-TPO negativo, ultrassonografia de tireoide normal. Cálcio, hemograma e vitamina B12 normais. A hidrocortisona e a fludrocortisona serão iniciadas hoje. Em relação ao TSH, a conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE
anti-TPO negativo

Resolução. Vitiligo e insuficiência adrenal autoimune levam a pensar em síndrome poliglandular tipo 2, e o TSH alto parece completar a tríade com tireoidite de Hashimoto; quem lembra que a levotiroxina não pode vir antes do cortisol tende a iniciá-la logo depois da hidrocortisona. Mas o cortisol exerce efeito inibitório sobre a secreção de TSH, e sua deficiência eleva o TSH de forma discreta e reversível. Com T4 livre normal, anti-TPO negativo e tireoide de aspecto normal, não há evidência de doença tireoidiana autoimune. A conduta é repor glicocorticoide e mineralocorticoide e repetir o TSH em algumas semanas: muitas vezes ele normaliza, e a

levotiroxina se torna desnecessária. Se persistir alto, o hipotireoidismo é real e a reposição começa com o cortisol já corrigido.

A) Repetir o TSH após a reposição de glicocorticoide CORRETA
Correta. TSH discretamente alto com T4 livre normal e anti-TPO negativo na insuficiência adrenal não tratada pode ser efeito da falta de cortisol e normalizar com a reposição.

B) Levotiroxina em dose baixa iniciada hoje
Errada. Levotiroxina antes de corrigir o cortisol acelera a depuração do cortisol restante e pode precipitar crise adrenal; seria errada mesmo com hipotireoidismo confirmado.

C) Levotiroxina após 48 horas de hidrocortisona ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a ordem cortisol antes da tireoide é correta quando há hipotireoidismo real, mas aqui não há evidência de doença tireoidiana, e o TSH pode normalizar sozinho.

D) Cintilografia de tireoide com captação
Errada. Cintilografia seria útil para investigar tireotoxicose com TSH suprimido, e não TSH discretamente elevado.

Para levar. Na insuficiência adrenal não tratada, o TSH pode subir só pela falta de cortisol: com T4 livre normal e sem autoimunidade tireoidiana, reponha o glicocorticoide e repita o TSH antes de prescrever levotiroxina.

Bornstein SR et al. Diagnosis and treatment of primary adrenal insufficiency: Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2016; Husebye ES et al. Autoimmune polyendocrine syndromes. N Engl J Med 2018.

Revisa: UERJ recorrente: síndrome poliglandular tipo 2 + S1 q25; o TSH alto que é efeito da falta de cortisol, e não Hashimoto

---

20 Gastroenterologia e hepatologia · DHGNA aos 71 anos com FIB-4 de 1,9 e ALT elevada: baixo risco pelo ponto de corte de 2,0 acima dos 65 anos, sem elastografia

Limiar **Gabarito C**

Mulher de 71 anos, com hipertensão arterial, dislipidemia e obesidade (IMC de 31 kg/m²), sem diabetes (glicemia de jejum 98 mg/dL, HbA1c 5,6%), é encaminhada ao ambulatório por esteatose hepática moderada descrita em ultrassonografia feita para investigar cálculos. Usa losartana e atorvastatina há 6 anos. Nega consumo de álcool. Assintomática; sem estigmas de hepatopatia, baço não palpável. Exames: ALT 58 U/L (referência até 33), AST 44 U/L (referência até 32), GGT 70 U/L, plaquetas 215.000/mm³, albumina 4,2 g/dL, bilirrubinas normais. HBsAg, anti-HCV e anti-HIV não reagentes; ferritina 210 ng/mL com saturação de transferrina de 28%; FAN não reagente. O FIB-4 calculado é de 1,9. Ela pergunta se a estatina lesou o fígado. A conduta mais adequada para a avaliação de fibrose é:

O DADO QUE DECIDE

Mulher de 71 anos

Resolução. Com o ponto de corte inferior habitual de 1,3, um FIB-4 de 1,9 cai na faixa intermediária e levaria à elastografia, e a ALT elevada reforça a impressão de doença ativa. Mas a idade entra no numerador do FIB-4 e infla o escore em idosos, gerando excesso de falsos positivos; por isso, acima dos 65 anos, o limiar inferior validado é 2,0. Abaixo dele, a probabilidade de fibrose avançada é baixa, e a conduta é controle metabólico e nova estratificação com FIB-4 em 2 a 3 anos. A ALT não estratifica fibrose, e a estatina é segura na doença

hepática gordurosa e deve ser mantida. O limiar superior de 2,67 não muda com a idade, e apenas valores na nova faixa intermediária (2,0 a 2,67) pediriam elastografia.

A) Elastografia por ressonância magnética
Errada. A elastografia por ressonância é alternativa de segunda linha para casos de risco intermediário, que não é o desta paciente.

B) Biópsia hepática percutânea
Errada. Biópsia fica para dúvida diagnóstica ou testes não invasivos discordantes, e não para baixo risco pelo FIB-4.

C) Repetir o FIB-4 em 2 a 3 anos CORRETA
Correta. Acima de 65 anos, FIB-4 abaixo de 2,0 indica baixo risco de fibrose avançada: reestratificar em 2 a 3 anos.

D) Elastografia hepática transitória agora ARMADILHA
Errada. Seria o passo com FIB-4 de 1,9 em paciente abaixo de 65 anos; aos 71, o limiar inferior é 2,0 e o escore está abaixo dele.

Para levar. O FIB-4 tem limiar inferior de 1,3 abaixo dos 65 anos e de 2,0 a partir dos 65; a ALT não muda a estratificação de fibrose, e a estatina se mantém.

AASLD Practice Guidance on the clinical assessment and management of NAFLD, 2023; EASL-EASD-EASO Clinical Practice Guidelines on MASLD, 2024; McPherson S et al. Am J Gastroenterol 2017.

Revisa: UERJ recorrente: DHGNA e FIB-4 (1,3 e 2,67), aqui pelo ajuste do limiar à idade

---

21

Hematologia · Síndrome mielodisplásica com del(5q) isolada, anemia dependente de transfusão e eritropoetina sérica alta: baixo risco e lenalidomida, e não eritropoetina

Grade X / Y **Gabarito D**

Mulher de 74 anos, hipertensa e com osteoartrite, é encaminhada por anemia macrocítica progressiva há 1 ano, hoje dependente de 2 unidades de concentrado de hemácias por mês. Usa losartana e fez reposição de vitamina B12 intramuscular por 3 meses, prescrita pela UBS, sem resposta. Nega etilismo, sangramentos e perda de peso. Exame: palidez, sem esplenomegalia nem linfonodomegalias. Hemoglobina 7,6 g/dL, VCM 108 fL, reticulócitos 0,6%, leucócitos 4.300/mm³ com 2.100 neutrófilos, plaquetas 410.000/mm³. B12, folato, TSH, função renal e hepática normais; ferritina 860 ng/mL. Mielograma: medula normocelular com megacariócitos hipolobulados e mononucleares, displasia eritroide e 2% de blastos, sem sideroblastos em anel. Cariótipo: 46,XX,del(5q) isolada em 18 de 20 metáfases. Eritropoetina sérica de 820 mUI/mL. A filha pergunta se a mãe tem leucemia e se precisará de transplante. A categoria de risco e o tratamento mais adequado são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

Eritropoetina sérica de 820 mUI/mL

Resolução. A idade, a dependência transfusional e a pergunta da filha sobre leucemia empurram para alto risco, mas o que classifica a síndrome mielodisplásica é o IPSS-R: blastos abaixo de 5%, del(5q) isolada (citogenética de bom prognóstico) e citopenia de uma linhagem, com plaquetas até altas, configuram baixo risco. No baixo risco com anemia sintomática, a eritropoetina recombinante é a primeira linha quando a

eritropoetina sérica é baixa (até 500 mUI/mL) e a carga transfusional é pequena; aqui ela está em 820 mUI/mL, com 2 unidades por mês, e a chance de resposta é mínima. A del(5q) isolada tem tratamento dirigido: lenalidomida, que leva à independência transfusional na maioria dos casos. Azacitidina e transplante alogênico ficam para o alto risco, e a falha da B12 só reforça que a macrocitose é medular.

A) Baixo risco / eritropoetina recombinante ARMADILHA

Errada, e é a armadilha. Eritropoetina recombinante é a escolha no baixo risco sem del(5q) ou com eritropoetina sérica até 500 mUI/mL; com 820 mUI/mL e alta carga transfusional, a resposta é improvável.

B) Alto risco / azacitidina

Errada nas duas metades. Azacitidina é para síndrome mielodisplásica de alto risco (excesso de blastos ou citogenética desfavorável), e aqui os blastos são 2% com del(5q) isolada.

C) Alto risco / transplante alogênico

Errada nas duas metades. Transplante alogênico é para alto risco em paciente elegível; ela é de baixo risco e tem 74 anos.

D) Baixo risco / lenalidomida CORRETA

Correta. Blastos de 2% com del(5q) isolada é baixo risco, e a anemia dependente de transfusão com eritropoetina sérica alta pede lenalidomida.

Para levar. Síndrome mielodisplásica: o risco vem do IPSS-R (blastos, cariótipo, citopenias), e não da idade. No baixo risco com anemia, eritropoetina recombinante se a eritropoetina sérica for até 500 mUI/mL; del(5q) isolada com dependência transfusional, lenalidomida.

NCCN Guidelines Myelodysplastic Syndromes (2025); Greenberg PL et al., IPSS-R, Blood 2012.

Revisa: UERJ oncohematologia por subtipo (citogenética que muda a conduta) + S2 q61 (rótulo de SMD sem ler o dado que decide)

22

Emergência e UTI · Lactato subindo no choque séptico já reperfundido da asmática em nebulização contínua de salbutamol: hiperlactatemia adrenérgica, e não nova expansão

Droga a deduzir **Gabarito C**

Mulher de 41 anos, com asma grave, é internada na UTI com pneumonia pneumocócica e choque séptico. Recebeu 30 mL/kg de Ringer lactato nas primeiras 3 horas, ceftriaxona com azitromicina, metilprednisolona 40 mg de 6 em 6 horas e salbutamol por nebulização contínua (10 mg/hora) desde a admissão, além de noradrenalina, hoje em 0,06 mcg/kg/min e em redução. Na 6ª hora: PA 118/70 mmHg (PAM 86 mmHg), FC 128 bpm, extremidades quentes, tempo de enchimento capilar de 2 segundos, diurese de 1,2 mL/kg/h, SvcO2 76%; sibilos esparsos, sem uso de musculatura acessória. Ultrassonografia: linhas B bilaterais que não existiam na admissão. Glicemia 248 mg/dL, potássio 3,1 mEq/L. Lactato arterial de 3,8 mmol/L na admissão e de 5,9 mmol/L agora; pH 7,31, bicarbonato 17 mEq/L. A conduta mais adequada neste momento é:

> O DADO QUE DECIDE
>
> *salbutamol por nebulização contínua (10 mg/hora)*

Resolução. Lactato que sobe na 6ª hora de choque séptico costuma ser lido como hipoperfusão persistente, e o reflexo é mais volume. Todos os marcadores de perfusão, porém, melhoraram: PAM de 86 com noradrenalina em queda, enchimento capilar de 2 segundos, extremidades quentes, diurese boa e SvcO2 de

76%. O que explica a dissociação é a droga: o agonista beta-2 em dose alta estimula a glicólise aeróbia e gera hiperlactatemia do tipo B, e a hiperglicemia, a hipocalemia e a taquicardia completam a assinatura adrenérgica. Com o broncoespasmo controlado, reduz-se o salbutamol e mantém-se a reanimação, acompanhando o lactato e o enchimento capilar, que a SSC 2021 sugere usar junto com o lactato. Mais volume agora, com linhas B novas, só traria congestão, e não há sinal de falha antimicrobiana nem de baixo débito.

A) Nova expansão com 30 mL/kg de cristaloide ARMADILHA
Errada. É a armadilha do lactato; seria a conduta com hipoperfusão clínica e responsividade a volume, mas a perfusão periférica normalizou e há linhas B novas.

B) Associar dobutamina para elevar a oferta de oxigênio
Errada. Seria pensada com disfunção miocárdica e SvcO2 baixa apesar de pressão adequada; aqui a SvcO2 é de 76% e as extremidades estão quentes.

C) Reduzir o salbutamol e manter a reanimação atual CORRETA
Correta. A hiperlactatemia acompanha hiperglicemia, hipocalemia e taquicardia sob salbutamol em dose alta, com perfusão normalizada: efeito adrenérgico, e não hipoperfusão.

D) Ampliar o antibiótico para meropeném e vancomicina
Errada. Ampliar o espectro seria razoável com piora clínica ou germe resistente; a paciente melhora em todos os parâmetros de perfusão, e o pneumococo é coberto.

Para levar. Lactato que sobe com perfusão periférica normalizada pede procurar causa do tipo B (agonista beta-2, adrenalina, metformina, linezolida) antes de mais volume; a SSC 2021 sugere guiar a reanimação também pelo enchimento capilar.

Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock (2021); ANDROMEDA-SHOCK (JAMA, 2019); GINA (2026).

Revisa: UERJ recorrente: sepse e lactato + S4 q73 (a droga em uso explica o achado que parece gravidade)

23

Neurologia · Parkinson sem resposta à levodopa com hipotensão ortostática sem taquicardia atribuída à tansulosina: atrofia de múltiplos sistemas e o sinal da cruz na ponte

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Homem de 62 anos, com diagnóstico de doença de Parkinson há 3 anos, retorna por piora. O quadro começou com lentidão e rigidez bilaterais e simétricas, sem tremor de repouso; usa levodopa/benserazida com 1.000 mg/dia de levodopa há 1 ano, sem melhora perceptível. Há 4 anos tem disfunção erétil e, há 2, urgência e incontinência urinária, atribuídas à hiperplasia prostática e tratadas com tansulosina. Refere tontura ao se levantar e duas quedas: PA 132/80 mmHg deitado e 92/60 mmHg após 3 minutos em pé, sem aumento da FC (68 para 70 bpm). A esposa relata que ele se debate durante os sonhos e tem um ruído agudo inspiratório durante a noite. Exame: bradicinesia e rigidez simétricas, voz trêmula e aguda, dismetria leve à prova índex-nariz, movimentos oculares verticais preservados, cognição normal. Na RM de encéfalo, o achado esperado é:

O DADO QUE DECIDE

sem aumento da FC (68 para 70 bpm)

Resolução. O rótulo de doença de Parkinson e a tansulosina oferecem explicação para tudo: a urgência seria da próstata e a hipotensão, do alfabloqueador, e a RM seria normal. Mas a hipotensão por droga vem com taquicardia reflexa, e aqui a FC não se mexe ao levantar: é hipotensão ortostática neurogênica, falência autonômica. Somada a parkinsonismo simétrico sem resposta a 1.000 mg/dia de levodopa, disfunção erétil e urinária precedendo o quadro motor, estridor noturno, distúrbio comportamental do sono REM e sinais cerebelares, configura atrofia de múltiplos sistemas. Na RM, a degeneração das fibras pontocerebelares transversas com rafe mediana produz a hiperintensidade cruciforme na ponte em T2, com atrofia de ponte e pedúnculos cerebelares médios. Olhar vertical preservado e cognição normal afastam a paralisia supranuclear progressiva e a hidrocefalia de pressão normal.

A) Atrofia mesencefálica com ponte preservada
Errada. Seria o achado da paralisia supranuclear progressiva, que tem quedas e pouca resposta à levodopa, mas com paralisia do olhar vertical, aqui preservado, e sem falência autonômica precoce.

B) Hiperintensidade cruciforme na ponte em T2 CORRETA
Correta. Falência autonômica com hipotensão ortostática sem taquicardia, estridor e sinais cerebelares em parkinsonismo refratário à levodopa é atrofia de múltiplos sistemas.

C) Ausência de alterações estruturais ARMADILHA
Errada. É a armadilha do rótulo: na doença de Parkinson a RM é normal, mas a ausência de resposta à levodopa e a hipotensão sem taquicardia não cabem nela nem na tansulosina.

D) Ventrículos dilatados com sulcos altos apertados
Errada. Seria a hidrocefalia de pressão normal, com marcha magnética, incontinência e declínio cognitivo, sem disautonomia cardiovascular nem estridor.

Para levar. Hipotensão ortostática sem aumento da FC é neurogênica, não de droga; com parkinsonismo que não responde à levodopa e estridor, é atrofia de múltiplos sistemas, e a RM mostra o sinal da cruz na ponte.

Wenning GK et al. Movement Disorder Society Criteria for the Diagnosis of Multiple System Atrophy, Mov Disord 2022; Freeman R et al. Consensus statement on the definition of orthostatic hypotension, Clin Auton Res 2011.

Revisa: S1 q39 e UERJ recorrente: parkinsonismo que não é doença de Parkinson; agora a atrofia de múltiplos sistemas escondida atrás da tansulosina

---

24 Cardiologia · Hipertensão arterial pulmonar na esclerose sistêmica limitada: P2 hiperfonética e sopro de insuficiência tricúspide, e não a ausculta da CIA

Grade X / Y **Gabarito D**

Mulher de 54 anos tem esclerose sistêmica cutânea limitada há 14 anos, com fenômeno de Raynaud, esclerodactilia, telangiectasias faciais e anticorpo anticentrômero positivo. Há 1 ano apresenta dispneia progressiva, hoje aos pequenos esforços, e teve um episódio de síncope ao subir escadas. Ao exame: PA 112 x 72 mmHg, FC 96 bpm, SatO2 93% em repouso, turgência jugular com onda v proeminente, impulsão paraesternal esquerda sustentada e edema de membros inferiores. Espirometria: CVF de 88% do previsto, com DLCO de 36%. TC de tórax de alta resolução sem doença intersticial. ECG: desvio do eixo para a direita e padrão rSR' em V1. Ecocardiograma: dilatação de átrio e ventrículo direitos, PSAP estimada em 72 mmHg, septo interatrial íntegro ao estudo com microbolhas e valvas esquerdas normais. Na ausculta, espera-se encontrar, quanto à segunda bulha e ao sopro, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

septo interatrial íntegro ao estudo com microbolhas

Resolução. Câmaras direitas dilatadas, eixo para a direita e rSR' em V1 formam o quadro eletrocardiográfico e ecocardiográfico da comunicação interatrial ostium secundum, cuja ausculta é desdobramento fixo de B2 com sopro ejetivo pulmonar por hiperfluxo. Mas o septo interatrial está íntegro ao estudo com microbolhas, e a sobrecarga direita tem outra causa: hipertensão arterial pulmonar da esclerose sistêmica limitada, sugerida pela DLCO muito reduzida com CVF preservada e pulmão sem intersticiopatia. A síncope ao esforço indica doença avançada. Na hipertensão pulmonar, o componente pulmonar da B2 fica hiperfonético (às vezes palpável), e a dilatação do ventrículo direito causa insuficiência tricúspide, com sopro holossistólico na borda esternal esquerda baixa que aumenta na inspiração (sinal de Rivero-Carvallo) e onda v proeminente no pulso venoso. Pode haver ainda sopro diastólico de Graham Steell.

A) Desdobramento fixo de B2 / sopro ejetivo pulmonar ARMADILHA
Errada. É a ausculta da comunicação interatrial, que o ECG e a dilatação direita sugerem; o estudo com microbolhas excluiu o shunt.

B) B2 única / sopro ejetivo que diminui na inspiração
Errada. B2 única com sopro ejetivo é achado da estenose aórtica grave, de câmaras esquerdas; as valvas esquerdas são normais.

C) P2 hiperfonética / ruflar diastólico apical
Errada. Ruflar apical com P2 hiperfonética é da estenose mitral com hipertensão pulmonar pós-capilar; a mitral é normal ao eco.

D) P2 hiperfonética / sopro sistólico que aumenta na inspiração CORRETA
Correta. Hipertensão pulmonar com ventrículo direito dilatado dá P2 hiperfonética e insuficiência tricúspide com Rivero-Carvallo.

Para levar. Esclerose sistêmica limitada com DLCO desproporcionalmente baixa e pulmão sem fibrose é hipertensão arterial pulmonar: P2 hiperfonética, sopro de insuficiência tricúspide que aumenta na inspiração e onda v no pulso jugular.

2022 ESC/ERS Guidelines for the diagnosis and treatment of pulmonary hypertension; 7th World Symposium on Pulmonary Hypertension (2024); Recomendações da SBR para o tratamento da esclerose sistêmica, 2024.

Revisa: S4 q38 (CIA pelo ECG) e achado esperado 0 de 8: a sobrecarga direita que imita CIA, lida pela ausculta

---

25

Reumatologia · Plaquetopenia grave com sangramento em lúpica febril, sem esquizócitos e com LDH normal: PTI secundária, corticoide com imunoglobulina e não plasmaférese

Negativo no meio | Gabarito A

Mulher de 26 anos, com lúpus há 2 anos (artrite, fotossensibilidade, FAN e anti-DNA reagentes), em uso de hidroxicloroquina, teve quadro gripal há 1 semana. Há 5 dias surgiram petéquias em membros inferiores, gengivorragia e epistaxe; há 2 dias, cefaleia leve e temperatura de 37,8 °C. Consciente, orientada, sem déficit focal, PA 118 × 72 mmHg, FC 92 bpm, sem esplenomegalia. Hb 12,1 g/dL, reticulócitos 1,2%, leucócitos 4.200/mm³, plaquetas 6.000/mm³. LDH 230 U/L (referência: até 250), bilirrubina indireta 0,5 mg/dL, haptoglobina normal, Coombs direto negativo. Esfregaço revisto pelo hematologista: macroplaquetas, sem

esquizócitos. Creatinina 0,8 mg/dL, urina sem hematúria ou proteinúria, C3 discretamente baixo. TC de crânio sem sangramento. A conduta inicial mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

Esfregaço revisto pelo hematologista: macroplaquetas, sem esquizócitos

Resolução. Lúpus, febre, cefaleia e plaquetas de 6.000 lembram a pêntade da púrpura trombocitopênica trombótica e puxam para a plasmaférese. O que decide são os negativos: sem esquizócitos, LDH, bilirrubina indireta e haptoglobina normais e Hb preservada, não há hemólise microangiopática, e sem ela não há PTT. Plaquetopenia isolada com macroplaquetas é destruição periférica imune: púrpura trombocitopênica imunológica secundária ao lúpus, que pode ser desencadeada por infecção viral. Com plaquetas abaixo de 10.000 e sangramento de mucosa, o tratamento inicial é corticoide em dose alta (pulso de metilprednisolona ou dexametasona) associado a imunoglobulina venosa, que eleva as plaquetas em poucos dias. Rituximabe e agonista do receptor de trombopoetina ficam para a falha da primeira linha.

A) Corticoide e imunoglobulina venosa CORRETA
Correta. Plaquetopenia isolada com macroplaquetas, sem hemólise, com sangramento mucoso e plaquetas abaixo de 10.000 pede corticoide em dose alta com imunoglobulina venosa.

B) Plasmaférese e corticoide em dose alta ARMADILHA
Errada. Seria a conduta na PTT, que exige anemia hemolítica microangiopática com esquizócitos; aqui a Hb, a LDH e o esfregaço estão normais.

C) Transfusão de plaquetas isolada
Errada. A transfusão isolada é consumida rapidamente na destruição imune; fica para sangramento grave, junto com o tratamento específico.

D) Rituximabe e eltrombopague
Errada. São opções de segunda linha para PTI refratária ou dependente de corticoide, não o primeiro passo.

Para levar. Plaquetopenia grave no lúpus sem esquizócitos e sem hemólise é PTI secundária: corticoide em dose alta com imunoglobulina venosa quando há sangramento. Plasmaférese só com microangiopatia comprovada.

Fanouriakis A et al. EULAR recommendations for the management of SLE, 2023 update; Neunert C et al. American Society of Hematology 2019 guidelines for immune thrombocytopenia; Provan D et al. Updated international consensus report on ITP, Blood Adv 2019.

Revisa: S1 q51 pelo lado oposto: PTI secundária no LES, em que a ausência de esquizócitos tira a plasmaférese

---

26 Infectologia · Síndrome cardiopulmonar por hantavírus aberta como protocolo de sepse: volume cauteloso e vasopressor precoce

Rótulo verdadeiro | Gabarito A

Homem de 34 anos, agricultor no interior de Minas Gerais, há 2 semanas esvaziou um paiol de milho com muitos roedores. Há 4 dias tem febre, mialgia intensa, cefaleia e dor abdominal; há 12 horas surgiram tosse seca e dispneia progressiva. Temperatura 38,6 °C, PA 86/54 mmHg, FC 124 bpm, FR 34 irpm, SpO2 84% em ar ambiente, estertores crepitantes bilaterais, sem sufusão conjuntival e sem icterícia. Hemoglobina 18,2 g/dL, hematócrito 54% (referência: 40 a 50), leucócitos 18.000/mm³ com desvio e linfócitos atípicos, plaquetas 42.000/mm³, creatinina 1,4 mg/dL, bilirrubina total 0,8 mg/dL, CK 160 U/L, lactato 3,2 mmol/L. Radiografia:

infiltrado intersticial bilateral e pequeno derrame pleural bilateral. A equipe abriu o protocolo de sepse, colheu hemoculturas e iniciou ceftriaxona; é intubado. Além do suporte ventilatório, a conduta hemodinâmica mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

hematócrito 54% (referência: 40 a 50)

Resolução. Hipotensão, lactato alto, leucocitose com desvio e infiltrado bilateral cumprem o protocolo de sepse, que manda 30 mL/kg de cristaloide. Mas a exposição a roedores em paiol, a hemoconcentração com plaquetopenia e linfócitos atípicos, o edema pulmonar bilateral com derrame e a ausência de icterícia, de sufusão e de CK alta compõem a síndrome cardiopulmonar por hantavírus, e não leptospirose nem pneumonia bacteriana. Nela o choque é de extravasamento capilar pulmonar com depressão miocárdica, e a hemoconcentração reflete plasma fugindo para o pulmão: volume liberal piora o edema e a hipoxemia rapidamente. O manejo é reposição volêmica cautelosa, vasopressor e inotrópico precoces, ventilação protetora e, nos refratários, oxigenação extracorpórea. A ribavirina não tem benefício na forma cardiopulmonar, e corticoide não tem papel estabelecido. Manter o antibiótico até sair a investigação é aceitável, mas não muda a hemodinâmica.

A) Volume cauteloso e noradrenalina precoce CORRETA

Correta. Hemoconcentração com edema pulmonar após exposição a roedores pede volume cauteloso, noradrenalina e inotrópico precoces.

B) Ribavirina intravenosa iniciada precocemente

Errada. Tem algum papel na febre hemorrágica com síndrome renal das hantaviroses do Velho Mundo, mas não mostrou benefício na forma cardiopulmonar das Américas.

C) Pulso de metilprednisolona por 3 dias

Errada. Seria discutido na pneumonia grave com resposta inflamatória exuberante, mas não reduziu mortalidade no hantavírus e não corrige o choque.

D) Cristaloide 30 mL/kg nas primeiras 3 horas ARMADILHA

Errada. É a armadilha do protocolo de sepse: seria a certa no choque séptico bacteriano, mas no hantavírus o volume liberal agrava o edema pulmonar por extravasamento capilar.

Para levar. Choque com hemoconcentração, plaquetopenia e edema pulmonar após exposição a roedores silvestres é hantavírus: a ordem é volume cauteloso e vasopressor precoce, e não o bolus de sepse.

Ministério da Saúde, Guia de Vigilância em Saúde, 6ª ed. (2024), capítulo Hantavirose; Manual de Vigilância, Prevenção e Controle das Hantaviroses (MS, 2014); Surviving Sepsis Campaign (2021).

Revisa: S4 q29: hantavírus x pneumonia com sepse, agora o rótulo de sepse leva ao erro de conduta

---

27 Nefrologia · Hipercalcemia e hiperfosfatemia na hemodiálise com PTH abaixo de duas vezes o limite: sevelâmer e suspender o calcitriol

Grade X / Y **Gabarito D**

Mulher de 61 anos, diabética, em hemodiálise há 4 anos, usa carbonato de cálcio 1 g em cada refeição e calcitriol 0,5 mcg/dia, este iniciado há 18 meses, quando o PTH estava em 780 pg/mL. Queixa-se de prurido; a adesão à dieta é regular e as sessões são cumpridas. Exames atuais: cálcio 10,7 mg/dL (8,5 a 10,2), fósforo 6,8

mg/dL, fosfatase alcalina 70 U/L (normal), 25-hidroxivitamina D 34 ng/mL, PTH 110 pg/mL (referência do método 15 a 65). Kt/V de 1,4. Radiografia das mãos com calcificação das artérias digitais. A conduta mais adequada em relação ao quelante de fósforo e ao calcitriol é, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

PTH 110 pg/mL (referência do método 15 a 65)

Resolução. Prurido, fósforo alto e um PTH acima do valor de referência sugerem hiperparatireoidismo ainda ativo, e o cinacalcete parece natural porque reduz PTH sem subir o cálcio. Mas no paciente em diálise a meta do KDIGO é PTH entre 2 e 9 vezes o limite superior do método, aqui entre 130 e 585 pg/mL; 110 pg/mL está abaixo da faixa, com fosfatase alcalina normal, o que sugere supressão excessiva e risco de doença óssea adinâmica. Reduzir mais o PTH com cinacalcete agravaria isso. A hipercalcemia e a calcificação vascular vêm da carga de cálcio do quelante e do calcitriol: o quelante deve ser trocado por um sem cálcio, como o sevelâmer, e o calcitriol suspenso, o que também ajuda a reduzir o fósforo, cuja absorção intestinal ele aumenta.

A) Aumentar o carbonato de cálcio / manter o calcitriol
Errada. Aumentar o cálcio do quelante pioraria a hipercalcemia e a calcificação vascular; o KDIGO recomenda restringir quelantes à base de cálcio.

B) Trocar por sevelâmer / associar cinacalcete ARMADILHA
Errada. É a armadilha do PTH acima da referência do método: o cinacalcete serviria para PTH acima de 9 vezes o limite, mas aqui o PTH está abaixo da meta.

C) Manter o carbonato de cálcio / suspender o calcitriol
Errada. Suspender o calcitriol está certo, mas manter o carbonato de cálcio mantém a carga de cálcio em quem já tem hipercalcemia e artérias calcificadas.

D) Trocar por sevelâmer / suspender o calcitriol CORRETA
Correta. Hipercalcemia com calcificação vascular e PTH abaixo de 2 vezes o limite pedem quelante sem cálcio e suspensão do calcitriol.

Para levar. Na diálise, a meta de PTH é de 2 a 9 vezes o limite superior do método; abaixo disso com hipercalcemia, retire calcitriol e quelante com cálcio, e não acrescente cinacalcete.

KDIGO 2017 Clinical Practice Guideline Update for the Diagnosis, Evaluation, Prevention, and Treatment of CKD-MBD; Diretrizes da SBN para o Distúrbio Mineral e Ósseo na DRC (2021).

Revisa: UERJ recorrente: DRC e doença mineral óssea + S4 q7 (PTH lido sem a meta da DRC)

---

28 Endocrinologia · Idoso com demência, quedas e hipoglicemia noturna em uso de glibenclamida com HbA1c de 6,4% rotulada como bom controle: desintensificar suspendendo a sulfonilureia

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Homem de 82 anos, com diabetes tipo 2 há 25 anos, demência moderada (depende da filha para a medicação e o banho), doença renal crônica com TFGe de 38 mL/min/1,73 m² e duas quedas nos últimos 3 meses, uma delas de madrugada com sudorese, vem à consulta com o laudo do exame: 'diabetes bem controlado', HbA1c 6,4%. Usa metformina 500 mg duas vezes ao dia, glibenclamida 10 mg duas vezes ao dia, losartana e sinvastatina. A

filha mede a glicemia capilar só pela manhã, entre 98 e 130 mg/dL. Peso estável, sem poliúria ou polidipsia. PA 128 × 72 mmHg, sem hipotensão postural. Hemoglobina 12,8 g/dL. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

uma delas de madrugada com sudorese

Resolução. O laudo diz bom controle e as glicemias de jejum parecem confirmá-lo, o que leva a manter o esquema. Mas a HbA1c de 6,4% está abaixo da meta deste paciente: idoso com demência moderada, dependente para atividades básicas e com doença renal, para quem a ADA 2026 e a SBD recomendam alvo menos estrito (HbA1c abaixo de 8,0% a 8,5%) e evitar hipoglicemia acima de tudo. A queda de madrugada com sudorese sugere hipoglicemia noturna, que a medida apenas matinal não captura. A glibenclamida é a sulfonilureia de maior risco de hipoglicemia, tem metabólitos ativos de eliminação renal e não deve ser usada em idosos nem com TFGe de 38. A conduta é desintensificar: suspender a glibenclamida, mantendo a metformina em dose ajustada à função renal, e reavaliar.

A) Trocar por insulina basal em dose baixa
Errada. Insulina seria para hiperglicemia acima da meta; aqui o problema é excesso de tratamento, e a troca mantém o risco de hipoglicemia.

B) Trocar a glibenclamida por gliclazida
Errada. Gliclazida seria a sulfonilureia preferível se fosse preciso intensificar; aqui não é preciso, e qualquer secretagogo mantém o risco de hipoglicemia.

C) Suspender a glibenclamida CORRETA
Correta. HbA1c abaixo da meta com queda noturna e sudorese em idoso frágil pede desintensificação, começando pela sulfonilureia.

D) Manter o esquema atual ARMADILHA
Errada. É a armadilha do laudo: HbA1c de 6,4% seria uma boa meta num adulto saudável, mas neste idoso frágil está abaixo do alvo e vem acompanhada de hipoglicemia provável.

Para levar. No idoso frágil, HbA1c baixa com secretagogo ou insulina não é sucesso: é sinal de excesso de tratamento, e a conduta é desintensificar, retirando primeiro o que causa hipoglicemia.

ADA Standards of Care in Diabetes 2026, seções 6 e 13 (Older Adults); Diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes 2025, capítulo de diabetes no idoso.

Revisa: UERJ recorrente: metas glicêmicas da ADA/SBD por perfil de paciente; o rótulo de bom controle como distrator

---

29 Pneumologia · Derrame leitoso de longa data após tuberculose pleural, com triglicerídeos acima de 110: colesterol alto e cristais definem pseudoquilotórax

Limiar **Gabarito B**

Homem de 63 anos teve tuberculose pleural à direita há 14 anos, tratada por 6 meses com esquema completo e alta por cura. Há 1 ano nota dispneia aos médios esforços, sem febre, sem emagrecimento e sem sudorese noturna. Nunca fez cirurgia torácica, não teve trauma e não tem diagnóstico de linfoma. Ao exame, FR 18 irpm, SpO2 95%, macicez e murmúrio abolido no terço inferior direito. Radiografia e TC: derrame direito com espessamento pleural de 8 mm e calcificações, sem massas nem linfonodomegalias. Toracocentese: líquido de aspecto leitoso, que não clareia após centrifugação. Proteína 4,8 g/dL (sérica 7,0), LDH 380 U/L (sérica 210), glicose 82 mg/dL, pH 7,36, leucócitos 1.200/mm³ (linfócitos 70%), ADA 28 U/L, triglicerídeos 128 mg/dL,

colesterol 340 mg/dL, presença de cristais de colesterol à microscopia. Gram, pesquisa de BAAR, teste rápido molecular e culturas negativos; citologia oncótica negativa. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

presença de cristais de colesterol à microscopia

Resolução. O líquido leitoso e os triglicerídeos de 128 mg/dL, acima do limiar de 110 mg/dL, levam direto a quilotórax. Mas o limiar de triglicerídeos não basta quando o derrame é antigo: no pseudoquilotórax os triglicerídeos podem subir, e o que define é o colesterol acima de 200 mg/dL, a razão colesterol/triglicerídeos maior que 1 e, sobretudo, os cristais de colesterol, que confirmam o diagnóstico. O contexto fecha: derrame de anos, pleura espessada e calcificada, após tuberculose pleural (ou artrite reumatoide), sem trauma, cirurgia ou linfoma que lesassem o ducto torácico. No quilotórax, o colesterol costuma ser baixo e há quilomícrons. ADA de 28 U/L, linfocitose moderada e culturas e teste molecular negativos não sustentam tuberculose ativa.

A) Quilotórax ARMADILHA
Errada. É a armadilha do limiar: triglicerídeos acima de 110 mg/dL sugerem quilotórax, mas colesterol de 340 mg/dL e cristais de colesterol num derrame antigo de pleura espessada definem pseudoquilotórax; não houve lesão do ducto torácico.

B) Pseudoquilotórax CORRETA
Correta. Derrame crônico após tuberculose pleural, pleura espessada, colesterol acima de 200 mg/dL com cristais de colesterol.

C) Derrame pleural maligno
Errada. Seria considerado com massas, espessamento nodular ou citologia positiva; a TC não mostra lesão e a citologia foi negativa.

D) Tuberculose pleural reativada
Errada. A reativação teria febre, emagrecimento e ADA alta; ADA de 28 U/L, teste molecular e culturas negativos falam contra.

Para levar. Derrame leitoso antigo, com pleura espessada após tuberculose ou artrite reumatoide, colesterol acima de 200 mg/dL e cristais de colesterol é pseudoquilotórax, mesmo que os triglicerídeos passem de 110 mg/dL.

Light RW. Pleural Diseases, 6ª ed. (2013); BTS Guideline for pleural disease (2023); Diretrizes SBPT para doenças pleurais (2006).

Revisa: UERJ recorrente: derrame pleural (Light, quilotórax); cruza com S3 q57 e S4 q18 (o número que cruza o limiar não fecha o diagnóstico)

---

30 Hematologia · PTI recém-diagnosticada com 26.000 plaquetas e só petéquias: abaixo de 30.000 se trata, e toda PTI do adulto pede HIV e hepatite C, não medula

Grade X / Y **Gabarito D**

Homem de 46 anos, previamente hígido, sem uso de medicamentos, procura o ambulatório por pontos vermelhos nas pernas há 10 dias. Nega epistaxe, gengivorragia, hematúria, melena e cefaleia. Há 3 meses doou sangue com hemograma normal. Não bebe álcool. Exame: PA 124 × 78 mmHg, petéquias esparsas nos

tornozelos, sem equimoses, sem bolhas hemorrágicas na boca, sem linfonodomegalia, baço não palpável. Exames: Hb 14,2 g/dL, leucócitos 6.400/mm³ com diferencial normal, plaquetas 26.000/mm³ confirmadas em tubo com citrato, esfregaço com plaquetas grandes e sem esquistócitos ou células imaturas. TP, TTPa e fibrinogênio normais, função hepática e renal normais, TSH normal. O residente lembra que, num caso recente de PTI com 41.000 plaquetas sem sangramento, a conduta foi apenas observar. Quanto ao tratamento inicial e à investigação adicional, a conduta mais adequada é, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

plaquetas 26.000/mm³ confirmadas em tubo com citrato

Resolução. O caso anterior lembrado pelo residente é verdadeiro e correto: PTI do adulto com plaquetas acima de 30.000 e sem sangramento relevante se observa. O limiar é o que muda tudo aqui: com 26.000 plaquetas, recém-diagnosticada, assintomática ou só com sangramento cutâneo menor (petéquias), a ASH recomenda tratar com corticoide (prednisona por até 6 semanas ou dexametasona em pulso) em vez de observar, porque o risco de sangramento grave cresce abaixo de 30.000. A investigação mínima de toda PTI do adulto inclui sorologias para HIV e hepatite C, causas de PTI secundária que mudam o tratamento (a antiviral costuma elevar as plaquetas). Plaquetopenia isolada, com as outras séries e o esfregaço normais, baço não palpável e boa resposta esperada, não exige medula; ela fica para atipias, outras citopenias, sintomas sistêmicos ou falha ao tratamento. O tubo com citrato afasta pseudoplaquetopenia.

A) Observação / aspirado e biópsia de medula
Errada nas duas metades. Observação só caberia acima de 30.000, e a medula não é necessária na plaquetopenia isolada com esfregaço e demais séries normais.

B) Observação / sorologias para HIV e hepatite C ARMADILHA
Errada. É a armadilha do caso anterior: as sorologias estão certas, mas observar só é adequado acima de 30.000 plaquetas, e aqui são 26.000.

C) Corticoide / aspirado e biópsia de medula
Errada. O corticoide está certo, mas a medula fica para atipias (outras citopenias, esfregaço anormal, esplenomegalia, sintomas B) ou refratariedade, ausentes aqui.

D) Corticoide / sorologias para HIV e hepatite C CORRETA
Correta. Abaixo de 30.000 na PTI recém-diagnosticada se trata, mesmo só com petéquias, e HIV e hepatite C são pesquisados em todo adulto com PTI.

Para levar. PTI do adulto: acima de 30.000 sem sangramento, observar; abaixo de 30.000, corticoide mesmo só com petéquias. Sempre HIV e hepatite C; medula só se houver atipia ou falha.

Neunert C et al. American Society of Hematology 2019 guidelines for immune thrombocytopenia. Blood Adv 2019; Provan D et al. Updated international consensus report on immune thrombocytopenia. Blood Adv 2019.

Revisa: S3 q37 (PTI com 41.000 sem sangramento, observação): o limiar visto do outro lado, abaixo de 30.000, com a investigação de PTI secundária

31 Reumatologia · Anti-HBc reagente com anti-HBs protetor antes do rituximabe: profilaxia antiviral com entecavir, e não monitoramento

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Mulher de 58 anos, com artrite reumatoide soropositiva há 12 anos, teve falha a metotrexato em dose plena e a dois inibidores de TNF, e a equipe optou por iniciar rituximabe. Na triagem pré-tratamento: HBsAg não reagente, anti-HBc total reagente, anti-HBs de 46 mUI/mL, HBV-DNA indetectável, ALT 22 U/L. Anti-HCV e anti-HIV não reagentes, IGRA negativo e radiografia de tórax normal. Relata ter recebido transfusão em cirurgia aos 20 anos e nega vacinação contra hepatite B. Ultrassonografia abdominal sem sinais de hepatopatia crônica. Creatinina 0,8 mg/dL. Em relação à hepatite B, a conduta mais adequada ao iniciar o rituximabe é:

O DADO QUE DECIDE

anti-HBc total reagente

Resolução. O anti-HBs acima de 10 mUI/mL parece garantir imunidade, e o monitoramento seriado do HBV-DNA é a conduta aceita para quem tem hepatite B resolvida e vai usar inibidor de TNF ou outros imunossupressores de risco moderado. O que muda o risco é a droga: o anti-CD20 destrói linfócitos B e é a classe de maior risco de reativação na infecção resolvida (HBsAg negativo, anti-HBc positivo), com risco acima de 10%, mesmo com anti-HBs positivo. Nesse cenário as diretrizes indicam profilaxia com antiviral de alta barreira (entecavir ou tenofovir), iniciada antes ou junto com a primeira infusão e mantida por pelo menos 12 a 18 meses após a última dose. Vacinar não faz sentido em quem já teve contato com o vírus, e o anti-HBs não protege da reativação do DNA viral persistente no hepatócito.

A) Vacinação contra hepatite B antes da infusão
Errada. Seria a conduta para quem é suscetível (todos os marcadores negativos); a paciente já teve infecção, e a vacina não previne reativação.

B) Nenhuma, pelo anti-HBs protetor
Errada. O anti-HBs protetor reduz, mas não elimina, o risco de reativação, que com anti-CD20 continua alto.

C) Entecavir profilático, mantido após o término CORRETA
Correta. Anti-HBc reagente com HBsAg negativo e anti-CD20 é risco alto de reativação e pede entecavir profilático, mantido por meses após a última dose.

D) HBV-DNA seriado, antiviral se positivar ARMADILHA
Errada. É a conduta aceita para hepatite B resolvida com imunossupressor de risco moderado, como inibidor de TNF; com rituximabe, o risco pede profilaxia.

Para levar. HBsAg negativo com anti-HBc positivo: com rituximabe (anti-CD20), profilaxia com entecavir ou tenofovir mantida por 12 a 18 meses após o término, independentemente do anti-HBs; com inibidor de TNF, monitorar pode bastar.

Terrault NA et al. AASLD 2018 Hepatitis B Guidance; EASL 2017 Clinical Practice Guidelines on the management of hepatitis B virus infection; Brasil, Ministério da Saúde. PCDT de Hepatite B e Coinfecções, 2023.

Revisa: UERJ recorrente: drogas antirreumáticas e seus efeitos (risco de reativação do HBV pela classe do imunossupressor)

32 Cardiologia · Dupla lesão aórtica reumática com regurgitação predominante: pulso bisferiens, e não parvus et tardus

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Homem de 39 anos, natural do interior do Maranhão, teve febre reumática aos 12 anos e abandonou a penicilina benzatina aos 15. Há 1 ano tem dispneia aos esforços moderados e, há 2 meses, dor precordial em aperto ao subir ladeiras. Nega síncope. Ao exame: PA de 162 × 48 mmHg, FC 72 bpm, rítmico; ictus no 6º espaço intercostal, na linha axilar anterior, amplo e hiperdinâmico. Na ausculta, sopro sistólico ejetivo rude 3+/6 no foco aórtico, com frêmito, irradiado para as carótidas, e sopro diastólico aspirativo 3+/6 na borda esternal esquerda, mais audível com o paciente inclinado para a frente; B1 normal e sem estalido de abertura. ECG: sobrecarga ventricular esquerda. Radiografia: aumento da área cardíaca à custa do ventrículo esquerdo. O ecocardiograma está marcado para a semana seguinte. À palpação do pulso carotídeo, espera-se encontrar:

O DADO QUE DECIDE

PA de 162 × 48 mmHg

Resolução. O sopro sistólico ejetivo rude com frêmito irradiado para as carótidas e a angina são reais e puxam para estenose aórtica grave, cujo pulso é de amplitude pequena e ascensão lenta (parvus et tardus). Mas a pressão diferencial de 114 mmHg, com diastólica de 48 mmHg, e o ictus amplo, hiperdinâmico e desviado para baixo e para fora mostram sobrecarga de volume por insuficiência aórtica importante. Na febre reumática, a lesão aórtica costuma ser dupla, e o grande volume ejetado pela valva também gera sopro sistólico intenso e frêmito sem estenose grave. Quando a regurgitação predomina, ou quando há dupla lesão com estenose apenas moderada, o pulso carotídeo é bisferiens: dois picos sistólicos, sentidos na palpação. Estenose grave com pulso parvus et tardus seria incompatível com essa pressão diferencial.

A) Pulso bisferiens CORRETA
Correta. Dupla lesão aórtica com regurgitação predominante, denunciada pela pressão diferencial ampla, dá pulso com dois picos sistólicos.

B) Pulso alternante
Errada. Seria esperado na disfunção sistólica grave do ventrículo esquerdo, com terceira bulha e baixo débito; o ventrículo aqui é hiperdinâmico.

C) Pulso parvus et tardus ARMADILHA
Errada. É o pulso da estenose aórtica grave, que o sopro rude com frêmito sugere; a pressão diferencial de 114 mmHg o torna impossível.

D) Pulso paradoxal
Errada. Seria o achado do tamponamento cardíaco ou da asma grave; nada no caso sugere restrição ao enchimento.

Para levar. Sopro sistólico rude no foco aórtico não basta para estenose grave: com pressão diferencial ampla e ictus hiperdinâmico, a lesão predominante é a regurgitação, e o pulso é bisferiens.

2020 ACC/AHA Guideline for the Management of Patients With Valvular Heart Disease; Diretriz Brasileira de Valvopatias, SBC 2020; Braunwald's Heart Disease, 12ª ed. (2022), cap. Physical Examination of the Heart and Circulation.

Revisa: UERJ recorrente: semiologia valvar e IA com sinais periféricos + S3 dupla lesão e S4 q65 (achado esperado, 0 de 8)

33 Neurologia · Hemorragia subaracnóidea aneurismática nas primeiras horas, aneurisma ainda não tratado: nimodipina oral e PA sistólica abaixo de 160, e não hipertensão induzida

Grade X / Y **Gabarito D**

Mulher de 52 anos, hipertensa em uso irregular de losartana e tabagista, é trazida ao pronto-socorro 3 horas após cefaleia súbita e intensa durante esforço evacuatório, seguida de vômitos e rigidez de nuca. Está sonolenta, mas desperta ao chamado e obedece a comandos (Glasgow 14), sem déficit motor. PA 186 × 104 mmHg, FC 96 bpm. A TC de crânio mostra hemorragia subaracnóidea difusa nas cisternas da base, sem hidrocefalia, e a angiotomografia revela aneurisma sacular de 7 mm na artéria comunicante anterior. A equipe de neurocirurgia programa a embolização para a manhã seguinte, cerca de 18 horas depois. O residente lembra que, em outra paciente, internada na mesma semana no 6º dia de hemorragia subaracnóidea com afasia nova, a equipe elevou a pressão arterial com noradrenalina. Sódio 139 mEq/L, creatinina 0,8 mg/dL. Quanto ao bloqueador de canal de cálcio e ao alvo de pressão arterial até a oclusão do aneurisma, a conduta mais adequada é, respectivamente:

> **O DADO QUE DECIDE**
> *programa a embolização para a manhã seguinte, cerca de 18 horas depois*

Resolução. A outra paciente da enfermaria é um distrator verdadeiro: elevar a pressão é medida da isquemia cerebral tardia por vasoespasmo, que surge entre o 4º e o 14º dia e já com o aneurisma tratado. Aqui o aneurisma está aberto e o risco das primeiras horas é o ressangramento, que cresce com a pressão alta; por isso, até a oclusão, mantém-se a PA sistólica abaixo de 160 mmHg com droga titulável, evitando hipotensão. A nimodipina começa já no primeiro dia, por via oral (60 mg a cada 4 horas por 21 dias), porque melhora o desfecho neurológico; a forma venosa em bolus causa hipotensão e não tem o mesmo respaldo. As duas metades se decidem por dados diferentes: a via da nimodipina pela evidência, o alvo de pressão pelo aneurisma ainda não tratado.

A) Nimodipina venosa em bolus / PA sistólica acima de 180
Errada nas duas metades. Bolus venoso de nimodipina provoca hipotensão, e pressão alta com aneurisma não tratado aumenta o ressangramento.

B) Nimodipina oral / PA sistólica acima de 180 ARMADILHA
Errada na segunda metade, e é a armadilha. A nimodipina oral está certa, mas pressão induzida alta é tratamento do vasoespasmo com aneurisma já ocluído, e não das primeiras horas.

C) Nimodipina venosa em bolus / PA sistólica abaixo de 160
Errada na primeira metade. O alvo de pressão está certo, mas a nimodipina recomendada é oral; o bolus venoso derruba a pressão e compromete a perfusão.

D) Nimodipina oral / PA sistólica abaixo de 160 CORRETA
Correta. Nimodipina oral desde o primeiro dia e PA sistólica abaixo de 160 mmHg até a oclusão do aneurisma, para reduzir o ressangramento.

Para levar. Na hemorragia subaracnóidea, a pressão tem duas fases: antes de tratar o aneurisma, PA sistólica abaixo de 160 mmHg contra o ressangramento; depois, no vasoespasmo sintomático, pode-se elevar a pressão. A nimodipina oral começa no primeiro dia e vai até o 21º.

AHA/ASA Guideline for the Management of Patients With Aneurysmal Subarachnoid Hemorrhage (2023).

Revisa: UERJ recorrente: hemorragia subaracnóidea (vasoespasmo e nimodipina, UERJ 2025) + S1 q50 (HSA lida pela fase errada)

---

34 Infectologia · Reação hansênica tipo 1 com neurite durante a PQT no multibacilar: manter a PQT e prednisona, e não talidomida

Grade X / Y **Gabarito B**

Homem de 44 anos, com hanseníase dimorfa multibacilar (14 lesões, índice baciloscópico de 3,5 no diagnóstico), está no 4º mês de PQT-U com rifampicina, clofazimina e dapsona, com boa adesão. Há 10 dias, as lesões antigas tornaram-se eritematosas, edemaciadas e infiltradas, algumas com descamação, e surgiram dor no cotovelo direito e formigamento no 4º e 5º dedos da mão direita. Nega febre, artralgia, dor ocular e lesões novas; está preocupado que a doença esteja piorando apesar dos remédios. Temperatura 36,8 °C, PA 124/78 mmHg; nervo ulnar direito espessado e doloroso à palpação, com redução da força de abdução do 5º dedo em relação à avaliação inicial e perda de sensibilidade ao monofilamento de 2 g. Sem nódulos subcutâneos dolorosos. Hemograma e função hepática normais. Quanto à PQT e ao tratamento do quadro atual, respectivamente, a conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

as lesões antigas tornaram-se eritematosas, edemaciadas e infiltradas

Resolução. O paciente multibacilar com índice baciloscópico alto é o candidato habitual ao eritema nodoso hansênico, tratado com talidomida, e a preocupação dele puxa para a ideia de falha e suspensão da PQT. Mas o quadro é de reação tipo 1 (reversa): reagudização das lesões antigas, que ficam eritematosas, edemaciadas e infiltradas, com neurite, sem febre, sem nódulos dolorosos e sem acometimento sistêmico. A reação reversa é imunidade celular contra antígenos do bacilo, comum nas formas dimorfas e nos primeiros meses de tratamento, e não indica resistência nem falha. A PQT deve ser mantida, e a neurite com perda de força e sensibilidade pede prednisona 1 mg/kg/dia com redução lenta guiada pela avaliação neurológica, além de imobilização e acompanhamento da função. A talidomida não age na reação tipo 1.

A) Suspender a PQT / prednisona 1 mg/kg/dia
Errada. O corticoide está certo, mas a reação não é falha; interromper a PQT deixa a doença sem tratamento e não ajuda a reação.

B) Manter a PQT / prednisona 1 mg/kg/dia CORRETA
Correta. Reação tipo 1 com neurite: manter a PQT e iniciar prednisona 1 mg/kg/dia.

C) Manter a PQT / talidomida 100 a 400 mg/dia ARMADILHA
Errada. É a armadilha do multibacilar: seria a certa no eritema nodoso hansênico (nódulos dolorosos, febre, artralgia), mas não age na reação reversa.

D) Suspender a PQT / talidomida 100 a 400 mg/dia
Errada. Junta os dois erros: a reação não é motivo para suspender a PQT, e a talidomida é droga da reação tipo 2.

Para levar. Reação tipo 1 é reagudização das lesões antigas com neurite: prednisona 1 mg/kg/dia e PQT mantida. Talidomida é só para o eritema nodoso (tipo 2).

Ministério da Saúde, PCDT Hanseníase (2022); Guia Prático sobre a Hanseníase (MS, 2017); WHO Guidelines for the Diagnosis, Treatment and Prevention of Leprosy (2018).

Revisa: UERJ recorrente: hanseníase e reações, com o rótulo multibacilar que puxa para a talidomida

---

35

Gastroenterologia e hepatologia · Barrett indefinido para displasia sobre esofagite erosiva, encaminhado para ablação: dobrar o IBP e nova endoscopia em 6 meses

Rótulo verdadeiro

Gabarito B

Homem de 58 anos, tabagista de 30 maços-ano, IMC de 30 kg/m², com pirose há 15 anos, usa omeprazol 20 mg apenas quando tem sintomas. Fez endoscopia por pirose diária nos últimos 2 meses: epitélio colunar de Prague C4M6 e esofagite erosiva Los Angeles C sobreposta, sem lesão visível à cromoscopia digital. As biópsias pelo protocolo de Seattle mostraram metaplasia intestinal com laudo indefinido para displasia, confirmado por um segundo patologista com experiência em trato gastrointestinal. Nega disfagia, perda de peso ou anemia; Hb 14,2 g/dL. Foi encaminhado ao serviço de endoscopia intervencionista com pedido de ablação por radiofrequência, porque o médico assistente considerou que "indefinido equivale a displasia". A conduta mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

esofagite erosiva Los Angeles C sobreposta

Resolução. O segmento longo, o tabagismo, a obesidade e o laudo duvidoso confirmado por dois patologistas fazem parecer que é hora de erradicar o epitélio. Mas o laudo indefinido para displasia surge sobretudo quando há inflamação ativa, e aqui há esofagite erosiva grau C sobre o Barrett, que produz atipia reativa difícil de distinguir de displasia. A conduta é otimizar a supressão ácida, com IBP em dose dobrada, e repetir a endoscopia com biópsias em cerca de 6 meses, já sem esofagite: só então se reclassifica o epitélio. Ablação se indica para displasia confirmada, e ressecção endoscópica para lesão visível, ausente aqui. Tratar como Barrett sem displasia e espaçar a vigilância ignora a dúvida que a inflamação criou.

A) Ressecção endoscópica da mucosa
Errada. Ressecção endoscópica é para lesão visível ou nodular, que a cromoscopia não mostrou.

B) IBP duas vezes ao dia e endoscopia em 6 meses CORRETA
Correta. Com esofagite erosiva sobreposta, o laudo indefinido pede supressão ácida otimizada e nova endoscopia com biópsias em cerca de 6 meses.

C) Ablação por radiofrequência do segmento ARMADILHA
Errada. É a armadilha do rótulo: ablação se indica para displasia de baixo ou alto grau confirmada, e não para laudo indefinido sobre esofagite ativa.

D) Endoscopia de vigilância em 3 a 5 anos
Errada. Seria o intervalo de vigilância para Barrett sem displasia de segmento longo; o laudo indefinido não autoriza esse espaçamento.

Para levar. Barrett indefinido para displasia, sobretudo com esofagite ativa, pede IBP em dose otimizada e nova endoscopia com biópsias em cerca de 6 meses antes de qualquer terapia endoscópica.

ACG Clinical Guideline: Diagnosis and Management of Barrett's Esophagus, 2022; ESGE Position Statement on Barrett's esophagus, 2023.

Revisa: UERJ recorrente: DRGE e Barrett, aqui pelo laudo indefinido para displasia sobre esofagite ativa

---

36 Nefrologia · Pericardite com derrame após quadro gripal na DRC estágio 5 com fístula imatura: pericardite urêmica, indicação de diálise por cateter

Rótulo verdadeiro **Gabarito A**

Homem de 49 anos, com doença renal crônica por nefropatia hipertensiva, TFGe de 9 mL/min/1,73 m², está em preparo para diálise, com fístula arteriovenosa confeccionada há 5 semanas, ainda não maturada. Há 4 dias tem dor torácica que piora ao deitar e melhora ao sentar; na semana anterior teve coriza, odinofagia e febre por 3 dias. PA 150 × 90 mmHg, FC 92 bpm, sem pulso paradoxal, sem turgência jugular, atrito pericárdico audível. K 5,3 mEq/L, HCO3 18 mEq/L, ureia 210 mg/dL, hemoglobina 9,8 g/dL, troponina normal. ECG com complexos de baixa amplitude, sem supradesnivelamento de ST. Ecocardiograma: derrame pericárdico moderado, sem colapso de câmaras direitas. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

TFGe de 9 mL/min/1,73 m²

Resolução. O quadro gripal na semana anterior é verdadeiro e faz pensar em pericardite viral, tratada com colchicina e anti-inflamatório. No paciente com TFGe de 9 e ureia de 210, porém, a pericardite é urêmica até prova em contrário, e o ECG sem supradesnivelamento de ST reforça isso, porque a inflamação urêmica poupa o epicárdio. Pericardite urêmica é indicação absoluta de iniciar diálise, mesmo com potássio e bicarbonato toleráveis, e a fístula imatura não justifica espera: usa-se cateter, com heparina mínima ou nenhuma pelo risco de hemopericárdio. Anti-inflamatório não esteroide piora a função renal residual e não trata a causa. Sem tamponamento, a pericardiocentese não está indicada; ela fica para colapso de câmaras ou falha da diálise.

A) Hemodiálise por cateter, com heparina mínima CORRETA
Correta. Pericardite em DRC estágio 5 não dialítica é urêmica e indica diálise imediata, por cateter, com pouca ou nenhuma heparina.

B) Colchicina e ibuprofeno por duas semanas ARMADILHA
Errada. É a armadilha do quadro gripal: seria o tratamento da pericardite viral com função renal preservada, mas aqui a uremia é a causa e o anti-inflamatório lesa o rim residual.

C) Pericardiocentese guiada por ecocardiograma
Errada. A pericardiocentese seria a conduta no tamponamento; o ecocardiograma não mostra colapso de câmaras nem há pulso paradoxal.

D) Aguardar a maturação da fístula
Errada. A fístula imatura não adia indicação absoluta de diálise; aguardar expõe a tamponamento e hemopericárdio.

Para levar. Pericardite na DRC avançada sem diálise é urêmica e indica diálise imediata, por cateter se a fístula não está pronta, com heparina mínima; anti-inflamatório não é o tratamento.

KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of CKD; 2025 ESC Guidelines for the Management of Myocarditis and Pericarditis.

Revisa: UERJ recorrente: indicações de diálise; padrão do aluno de seguir o rótulo verdadeiro (S1 q37, S4 q66)

---

37 Endocrinologia · Hipercortisolismo leve em etilista pesado com fenótipo cushingoide sem estrias nem miopatia: pseudo-Cushing, abstinência e repetir os testes

Rótulo verdadeiro **Gabarito C**

Homem de 51 anos é encaminhado com o diagnóstico de síndrome de Cushing. Refere ganho de 9 kg em 2 anos, concentrado no abdome, face arredondada e hipertensão de difícil controle. Consome cerca de 10 doses de destilado por dia há 15 anos e nega uso de corticoide em qualquer via, inclusive tópico ou inalatório. PA 158 x 96 mmHg, pletora facial, abdome globoso sem estrias violáceas, sem fraqueza muscular proximal e sem equimoses, com aranhas vasculares no tórax. GGT 410 U/L, AST 128 U/L, ALT 54 U/L, VCM 104 fL. Cortisol após 1 mg de dexametasona: 4,8 µg/dL (normal até 1,8). Cortisol salivar ao final da noite: 0,42 µg/dL (até 0,15). Cortisol livre urinário: 1,8 vez o limite superior. ACTH 32 pg/mL. A conduta mais adequada neste momento é:

O DADO QUE DECIDE

Consome cerca de 10 doses de destilado por dia há 15 anos

Resolução. Três testes de rastreio alterados e ACTH não suprimido parecem fechar um Cushing ACTH-dependente, e o passo seguinte seria a ressonância de sela. Mas o etilismo pesado ativa o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal e produz hipercortisolismo funcional (pseudo-Cushing), com fenótipo parecido e testes de rastreio positivos, em geral com elevação discreta, como o cortisol livre urinário abaixo de 2 a 3 vezes o limite. Os sinais que mais separam Cushing verdadeiro, estrias violáceas largas, miopatia proximal e equimoses fáceis, estão ausentes, e há estigmas de hepatopatia alcoólica. A conduta é a abstinência e a repetição dos testes após algumas semanas: no pseudo-Cushing eles normalizam. Investigar a etiologia antes de confirmar o hipercortisolismo autônomo leva a achados incidentais na sela e a procedimentos invasivos sem indicação.

A) Cateterismo de seios petrosos
Errada. O cateterismo é para Cushing ACTH-dependente confirmado com imagem hipofisária negativa ou duvidosa, e não antes de confirmar o hipercortisolismo.

B) Teste com 8 mg de dexametasona
Errada. A supressão com dose alta tenta separar a origem hipofisária da ectópica e só tem sentido depois de confirmado o Cushing verdadeiro.

C) Abstinência e repetição dos testes CORRETA
Correta. Etilismo pesado com elevações discretas e sem os sinais específicos sugere pseudo-Cushing, que se confirma pela normalização dos testes com a abstinência.

D) Ressonância magnética de sela turca ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a ressonância de sela é o passo no Cushing ACTH-dependente confirmado, mas o hipercortisolismo ainda não foi separado do funcional pelo álcool.

Para levar. Antes de procurar a origem do Cushing, confirme que ele é autônomo: etilismo pesado, depressão grave e obesidade grave causam hipercortisolismo funcional, e a etiologia só se investiga quando o excesso persiste fora dessas condições.

Nieman LK et al. The diagnosis of Cushing's syndrome: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2008; Fleseriu M et al. Consensus on diagnosis and management of Cushing's disease: a guideline update. Lancet Diabetes Endocrinol 2021.

Revisa: UERJ recorrente: Cushing e seus testes + S1 q35 e S4 q31; agora o hipercortisolismo funcional pelo álcool antes de qualquer imagem

---

38 MBE · Aplicar ao paciente de baixo risco o resultado de um ensaio em alto risco: o efeito relativo se mantém, a redução absoluta e o NNT mudam

Grade X / Y **Gabarito A**

Um ensaio clínico randomizado em pacientes de alto risco cardiovascular mostrou que um novo hipolipemiante reduziu a incidência de infarto em 5 anos de 20% no grupo placebo para 15% no grupo tratado, e o efeito relativo foi o mesmo em todos os subgrupos de risco. Um clínico quer aplicar o resultado a um paciente de 52 anos cujo risco de infarto em 5 anos, estimado por escore validado, é de 4%. Para esse paciente, a redução absoluta do risco e o número necessário para tratar em 5 anos são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

risco de infarto em 5 anos, estimado por escore validado, é de 4%

Resolução. Os números do ensaio (redução absoluta de 5 pontos e NNT de 20) são verdadeiros, mas valem para quem tem risco basal de 20%. O que se transporta de uma população para outra é o efeito relativo: a redução relativa do risco é (20 menos 15) dividido por 20, ou 25%, e o enunciado garante que ela foi constante entre os subgrupos. Aplicada ao risco basal de 4% do paciente, a redução absoluta é 25% de 4%, ou 1 ponto percentual, e o NNT é o inverso, 100 pacientes tratados por 5 anos para evitar um infarto. Confundir a redução relativa com a absoluta, ou o risco basal com a redução, gera as outras combinações. É por isso que o mesmo remédio vale muito mais para quem tem risco alto.

A) 1% / 100 CORRETA

Correta. Redução relativa de 25% sobre risco basal de 4% dá redução absoluta de 1 ponto e NNT de 100 em 5 anos.

B) 5% / 20 ARMADILHA

Errada. É a armadilha: seriam a redução absoluta e o NNT de um paciente com o risco basal do ensaio (20%), e não deste.

C) 25% / 4

Errada. Usa a redução relativa (25%) como se fosse absoluta; o inverso de 25% só seria o NNT se o efeito absoluto fosse esse.

D) 4% / 25

Errada. Toma o risco basal do paciente (4%) como redução absoluta; seria o resultado se o remédio eliminasse todos os infartos.

Para levar. Transporte o efeito relativo, não o absoluto: redução absoluta igual a risco basal do paciente vezes redução relativa, e NNT igual ao inverso da redução absoluta, no horizonte de tempo do estudo.

Guyatt G et al. Users' Guides to the Medical Literature, 3ª ed. (JAMA, 2015), cap. Applying results to individual patients; Fletcher RH, Fletcher SW, Fletcher GS. Epidemiologia Clínica: elementos essenciais, 6ª ed. (2021).

Revisa: S2 q6: cálculo de NNT (antes a conversão por pacientes-ano, agora o risco basal do paciente diferente do ensaio)

---

39 Cardiologia · Síncope sem pródromo com bloqueio bifascicular e BAV de 1º grau, Holter e eco normais: estudo eletrofisiológico, e não teste de inclinação

Negativo no meio · Gabarito A

Homem de 72 anos teve síncope há 5 dias enquanto estava em pé numa fila de banco, em dia quente, após 40 minutos de espera. Não houve pródromos: a esposa conta que ele caiu de repente, sem palidez prévia, e acordou em menos de 1 minuto, orientado, com corte no supercílio. Hipertenso, usa losartana e anlodipino; nega uso de outras drogas. Ao exame: PA 136 × 82 mmHg deitado e 130 × 80 mmHg após 3 minutos em pé, FC 68 bpm, sem sopros, sem déficit neurológico. ECG: ritmo sinusal, PR de 220 ms, bloqueio de ramo direito e bloqueio divisional anterossuperior, QRS de 138 ms. Holter de 24 horas sem pausas, sem bloqueio atrioventricular de segundo grau e sem arritmias ventriculares. Ecocardiograma: FE de 60%, sem valvopatia. Glicemia, eletrólitos e hemograma normais. O exame a ser feito em seguida, o mais adequado, é:

O DADO QUE DECIDE

Não houve pródromos

Resolução. Ficar em pé muito tempo num dia quente é gatilho de síncope reflexa, e o teste de inclinação parece o exame natural; o Holter e o eco normais ainda tranquilizam. Mas a síncope sem pródromos, com queda abrupta e trauma, num idoso com bloqueio de ramo direito, bloqueio divisional anterossuperior e PR prolongado, sugere bloqueio atrioventricular paroxístico, e um Holter de 24 horas normal não exclui um evento intermitente. Nas diretrizes, síncope inexplicada com bloqueio bifascicular, após avaliação não invasiva inconclusiva, deve seguir para estudo eletrofisiológico: intervalo HV de 70 ms ou mais, ou bloqueio infra-hissiano induzido, indica marca-passo definitivo. Se o estudo for negativo, o monitor de eventos implantável é o passo seguinte. A FE preservada afasta indicação primária de cardiodesfibrilador.

A) Estudo eletrofisiológico CORRETA
Correta. Síncope inexplicada com bloqueio bifascicular e eco e Holter normais tem indicação de estudo eletrofisiológico para medir o intervalo HV.

B) Ressonância cardíaca com realce tardio
Errada. Seria indicada para buscar sarcoidose ou miocardite em jovem com bloqueio de condução ou FE reduzida; não é o passo seguinte aqui.

C) Teste de inclinação ortostática ARMADILHA
Errada. É a armadilha do gatilho ortostático; seria útil na síncope com pródromo autonômico e ECG normal, não na síncope abrupta com doença de condução.

D) Teste ergométrico
Errada. Seria o exame para síncope durante o esforço; o episódio ocorreu em repouso, em pé.

Para levar. Síncope sem pródromo com bloqueio bifascicular e avaliação não invasiva negativa: estudo eletrofisiológico, e marca-passo se HV de 70 ms ou mais. Holter de 24 horas normal não exclui bloqueio paroxístico.

2018 ESC Guidelines for the diagnosis and management of syncope; 2021 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy; 2017 ACC/AHA/HRS Guideline for the Evaluation and Management of Patients With Syncope.

Revisa: UERJ recorrente: síncope e bloqueios + S2 q28 (síncope rotulada como benigna em doente de condução)

---

40 Reumatologia · Idoso com sinovite de mãos e edema depressível em luva de boxe, mas anti-CCP muito alto e erosão: artrite reumatoide de início tardio, e não RS3PE

Grade X / Y **Gabarito D**

Homem de 74 anos refere há 5 semanas início abrupto de dor e rigidez matinal de 2 horas em punhos e metacarpofalangeanas, com inchaço no dorso das duas mãos. Nega dor em cinturas escapular e pélvica, febre ou perda de peso. Colonoscopia de 1 ano atrás normal, PSA de 1,2 ng/mL e TC de tórax e abdome de 2 meses atrás, feita para seguimento de nódulo pulmonar, sem lesões novas. Exame: sinovite de punhos e de segunda e terceira metacarpofalangeanas bilaterais, edema depressível no dorso das mãos com aspecto de luva de boxe, tenossinovite dos flexores. VHS 64 mm/h, PCR 52 mg/L, hemograma normal. Fator reumatoide 22 UI/mL (referência: até 14) e anti-CCP de 236 U/mL (referência: até 20). Radiografia de mãos com erosão marginal na cabeça do segundo metacarpo direito. O diagnóstico e o tratamento mais adequados são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

anti-CCP de 236 U/mL (referência: até 20)

Resolução. Idoso, início abrupto e edema depressível em luva de boxe levam direto à sinovite remitente simétrica soronegativa com edema (RS3PE), tratada com prednisona em dose baixa. Mas a definição de RS3PE exige soronegatividade, e o anti-CCP mais de dez vezes acima do limite com erosão marginal já na apresentação definem artrite reumatoide de início tardio, que pode começar abruptamente e com edema distal. O fator reumatoide discretamente positivo pesa pouco no idoso; é o anti-CCP alto que muda o rótulo. Artrite reumatoide com marcador de mau prognóstico (anti-CCP alto, erosão precoce) se trata com metotrexato desde o diagnóstico, com corticoide em dose baixa só como ponte. O rastreio de neoplasia, que importaria na RS3PE com resposta ruim ao corticoide, está em dia e não muda a decisão.

A) RS3PE / prednisona isolada em dose baixa ARMADILHA
Errada. Seria o tratamento da RS3PE, que exige soronegatividade; anti-CCP de 236 U/mL com erosão define artrite reumatoide.

B) RS3PE / metotrexato e corticoide ponte
Errada. O diagnóstico de RS3PE cai pela sorologia, e a RS3PE responde a corticoide isolado, sem necessidade de metotrexato.

C) Artrite reumatoide de início tardio / prednisona isolada em dose baixa
Errada. O diagnóstico está certo, mas corticoide isolado deixa progredir uma artrite reumatoide erosiva e de mau prognóstico.

D) Artrite reumatoide de início tardio / metotrexato e corticoide ponte CORRETA
Correta. Anti-CCP alto e erosão marginal definem artrite reumatoide de início tardio, que pede metotrexato com corticoide ponte.

Para levar. Edema depressível de mãos no idoso não é sinônimo de RS3PE: a RS3PE é soronegativa por definição. Anti-CCP alto ou erosão definem artrite reumatoide de início tardio, que se trata com metotrexato.

Smolen JS et al. EULAR recommendations for the management of rheumatoid arthritis, 2022 update; Fraenkel L et al. 2021 ACR Guideline for the Treatment of Rheumatoid Arthritis; Karmacharya P et al. RS3PE revisited: a systematic review, J Rheumatol 2016.

Revisa: S1 q71: RS3PE, agora pelo critério de definição (soronegatividade) contra artrite reumatoide de início tardio

---

41 Infectologia · Antígeno criptocócico reagente na aids com déficit focal discreto: TC de crânio antes da punção lombar

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Homem de 36 anos vive com HIV e abandonou a TARV há 2 anos; o último CD4, de 1 ano atrás, era 60 células/mm³. Há 3 semanas tem cefaleia progressiva, febre vespertina e vômitos, e há 2 dias está sonolento. Temperatura 38,2 °C, PA 128/80 mmHg, FC 96 bpm, Glasgow 14 (confuso), rigidez de nuca discreta, pupilas isocóricas e fundoscopia prejudicada por pouca colaboração. No exame motor, força preservada nos quatro membros, com desvio pronador discreto do membro superior direito e reflexos simétricos. O teste rápido de antígeno criptocócico (fluxo lateral) no soro é reagente, e a sorologia IgG para toxoplasmose também é reagente. O plantonista quer puncionar logo para medir a pressão de abertura. O próximo passo mais adequado é:

> O DADO QUE DECIDE
> *desvio pronador discreto do membro superior direito*

Resolução. O antígeno criptocócico sérico reagente, com cefaleia subaguda e febre, é verdadeiro e quase fecha neurocriptococose, e a punção com manometria é de fato indispensável para diagnóstico e para tratar a hipertensão intracraniana. O que muda a ordem é o exame neurológico: o desvio pronador é um sinal motor focal, e na aids avançada ele levanta lesão expansiva (neurotoxoplasmose, linfoma, criptococoma) que pode coexistir com a meningite. Imunossupressão grave, rebaixamento de consciência e qualquer déficit focal são indicações de imagem antes da punção, para não precipitar herniação. A TC é rápida e não atrasa o tratamento, e, sem lesão com efeito de massa, a punção vem logo em seguida. A sorologia para toxoplasma reagente só indica infecção latente e não autoriza tratar no escuro, e a anfotericina sem líquor perde o diagnóstico e o controle da pressão.

A) Anfotericina empírica sem punção lombar
Errada. A anfotericina pode até começar enquanto se aguarda, mas dispensar a punção deixa sem diagnóstico e sem controle da pressão intracraniana.

B) TC de crânio antes da punção lombar CORRETA
Correta. Aids avançada, rebaixamento e desvio pronador pedem TC antes da punção; sem efeito de massa, a punção com manometria segue de imediato.

C) Tratamento empírico para toxoplasmose
Errada. Seria a conduta com lesões com realce anelar na imagem e sorologia reagente; sem imagem, não há lesão a tratar.

D) Punção lombar imediata com manometria ARMADILHA

Errada. É a armadilha do antígeno reagente: seria a certa sem déficit focal e com consciência preservada, mas aqui há sinal motor e imunossupressão grave.

Para levar. Na aids, antígeno criptocócico reagente não pula a imagem: déficit focal, rebaixamento ou imunossupressão grave pedem TC antes da punção, e a manometria vem logo depois.

IDSA Practice Guidelines for the Management of Bacterial Meningitis (2004) e Cryptococcal Disease (2010); Ministério da Saúde, PCDT para Manejo da Infecção pelo HIV em Adultos (2024); WHO Guidelines for Cryptococcal Disease in HIV (2022).

Revisa: UERJ recorrente: TC antes da punção na aids, com o antígeno criptocócico como rótulo que puxa para puncionar já

42

Hematologia · Polineuropatia desmielinizante refratária à imunoglobulina com trombocitose, lambda e lesão óssea esclerótica: síndrome POEMS, e não CIDP

Rótulo verdadeiro **Gabarito B**

Homem de 52 anos acompanhado há 10 meses por parestesias ascendentes e fraqueza distal simétrica e progressiva, hoje com marcha escarvante. A eletroneuromiografia mostrou polineuropatia desmielinizante com componente axonal, e o líquor, proteína de 138 mg/dL com 2 células/mm³; recebeu o diagnóstico de polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória crônica e fez dois ciclos de imunoglobulina intravenosa e prednisona, sem melhora. Nos últimos meses notou escurecimento da pele, pequenas pápulas vermelho-violáceas no tronco, aumento das mamas e inchaço das pernas. Exame: PA 128 × 80 mmHg, edema 2+/4 em membros inferiores, fígado a 3 cm do rebordo, baço palpável, sem macroglossia, sem hipotensão postural. Exames: Hb 15,9 g/dL, plaquetas 640.000/mm³, creatinina 0,8 mg/dL, cálcio 9,1 mg/dL, TSH 7,8 mUI/L, testosterona baixa. Imunofixação com pequena banda IgA lambda; relação kappa/lambda das cadeias livres de 0,9. A TC de bacia mostra lesão esclerótica de 2 cm no ilíaco esquerdo. O diagnóstico mais provável é:

O DADO QUE DECIDE

lesão esclerótica de 2 cm no ilíaco esquerdo

Resolução. O rótulo de polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória crônica é verdadeiro na eletroneuromiografia e no líquor, e é por isso que a síndrome POEMS costuma ser diagnosticada com atraso. A falta de resposta à imunoglobulina e ao corticoide é o primeiro alerta, e o resto do caso preenche a síndrome: polineuropatia e gamopatia monoclonal quase sempre lambda (critérios obrigatórios), lesão óssea esclerótica (critério maior), e organomegalia, edema, endocrinopatias (hipotireoidismo, hipogonadismo, ginecomastia), alterações de pele (hiperpigmentação, hemangiomas glomeruloides) e trombocitose (critérios menores). O VEGF sérico elevado é o marcador que confirma. A amiloidose AL também é lambda e dá neuropatia, mas axonal, dolorosa, com disautonomia, e não produz lesão esclerótica, trombocitose nem hiperpigmentação. O mieloma cursa com lesões líticas, anemia e relação de cadeias leves alterada, e a policitemia e a trombocitose aqui vão no sentido oposto.

A) Amiloidose AL com neuropatia

Errada. Seria a hipótese com neuropatia axonal dolorosa, disautonomia, macroglossia ou síndrome nefrótica; amiloidose não faz lesão esclerótica nem trombocitose.

B) Síndrome POEMS CORRETA

Correta. Polineuropatia e gamopatia lambda com lesão óssea esclerótica, organomegalia, endocrinopatia, alterações cutâneas e trombocitose definem a síndrome POEMS.

C) Polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória crônica ARMADILHA

Errada. É a armadilha do rótulo: a eletroneuromiografia e o líquor são compatíveis, mas a refratariedade à imunoglobulina e a gamopatia lambda com lesão esclerótica mudam o diagnóstico.

D) Mieloma múltiplo com neuropatia

Errada. Mieloma produz lesões líticas, anemia, hipercalcemia ou lesão renal, e raramente neuropatia desmielinizante; aqui a hemoglobina e as plaquetas estão altas.

Para levar. Neuropatia desmielinizante que não responde à imunoglobulina, com gamopatia lambda, pede procurar lesão esclerótica e dosar VEGF: é a síndrome POEMS, tratada com radioterapia da lesão isolada ou terapia sistêmica.

Dispenzieri A. POEMS syndrome: 2023 update on diagnosis, risk-stratification, and management. Am J Hematol 2023; EAN/PNS guideline on chronic inflammatory demyelinating polyradiculoneuropathy 2021.

Revisa: UERJ recorrente: discrasias plasmocitárias (POEMS) escondidas atrás de um rótulo neurológico verdadeiro

---

43

Neurologia · AIT de alto risco com estenose carotídea sintomática de 75%: endarterectomia em até 2 semanas, e não dupla antiagregação isolada

Limiar **Gabarito A**

Homem de 69 anos, hipertenso, dislipidêmico e ex-tabagista, procura o pronto-socorro 18 horas após dois episódios no mesmo dia: perda visual monocular esquerda 'como uma cortina' por 5 minutos e, horas depois, fraqueza e dormência da mão direita com dificuldade para achar palavras por 40 minutos, ambos com recuperação completa. Usa losartana e sinvastatina 20 mg. PA 158/92 mmHg, FC 78 bpm regular, exame neurológico normal. ECG em ritmo sinusal; Holter de 24 horas com extrassístoles atriais frequentes, sem fibrilação atrial. RM de encéfalo sem lesão na difusão. Doppler e angiotomografia cervical: estenose de 75% na carótida interna esquerda e de 60% na direita. Ecocardiograma transtorácico normal. Além de AAS e estatina de alta potência, a conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

estenose de 75% na carótida interna esquerda

Resolução. AIT de alto risco, sem lesão na RM e sem fibrilação atrial, leva à dupla antiagregação por 21 dias dos estudos CHANCE e POINT. Esses estudos, porém, excluíram quem tinha indicação de revascularização carotídea. Os dois episódios (amaurose fugaz à esquerda e déficit motor e de linguagem à direita) são do território da carótida esquerda, que tem estenose de 75%: estenose sintomática acima de 70% tem indicação de endarterectomia, e o benefício é maior quanto mais cedo, idealmente nas primeiras 2 semanas. A carótida direita, com 60% e sem sintomas, não é a que causou o evento e não entra agora. As extrassístoles atriais não são fibrilação atrial e não indicam anticoagulação.

A) Endarterectomia esquerda nas próximas 2 semanas CORRETA

Correta. Estenose de 75% na carótida que explica os dois eventos: endarterectomia precoce, nas primeiras 2 semanas, com AAS e estatina.

B) Dupla antiagregação por 21 dias, sem cirurgia ARMADILHA

Errada. Seria a conduta no AIT de alto risco sem estenose carotídea cirúrgica nem fonte cardioembólica; aqui a estenose sintomática acima de 70% indica cirurgia.

C) Anticoagulação oral com apixabana
Errada. Seria a prevenção na fibrilação atrial; o Holter mostrou apenas extrassístoles atriais.

D) Endarterectomia bilateral após 3 meses
Errada. Adiar perde o benefício, que se concentra nas primeiras semanas, e a carótida direita assintomática não é a lesão responsável.

Para levar. No AIT, a primeira pergunta é a carótida: estenose sintomática de 70 a 99% vai para endarterectomia nas primeiras 2 semanas; a dupla antiagregação por 21 dias é para quem não tem essa indicação.

Kleindorfer DO et al. AHA/ASA Guideline for the Prevention of Stroke in Patients With Stroke and Transient Ischemic Attack, Stroke 2021; Naylor R et al. ESVS 2023 Clinical Practice Guidelines on the Management of Atherosclerotic Carotid and Vertebral Artery Disease.

Revisa: UERJ recorrente: AIT e prevenção secundária, com a dupla antiagregação (já cobrada no AVC menor) como armadilha diante da estenose cirúrgica

---

44

Pneumologia · Alta suspeita de apneia obstrutiva com poligrafia domiciliar normal mas registro curto: polissonografia completa em laboratório

Negativo no meio · **Gabarito D**

Homem de 49 anos, motorista de ônibus, procura atendimento por sonolência diurna há 1 ano, com dois cochilos ao volante no último mês. A esposa relata ronco alto e pausas respiratórias durante o sono. Tem hipertensão em uso de quatro anti-hipertensivos, incluindo espironolactona, com PA de 152 × 96 mmHg; não usa sedativos nem bebe álcool. IMC 36 kg/m², circunferência cervical de 45 cm, Mallampati IV. Escala de sonolência de Epworth: 15. TSH e hemograma normais. Fez poligrafia domiciliar (tipo 3, sem eletroencefalograma) que mostrou índice de apneia e hipopneia de 4 eventos/hora, com tempo de registro válido de 3 horas e 10 minutos; ele conta que naquela noite ficou acordado boa parte do tempo, incomodado com os sensores. O médico assistente considerou a apneia afastada e pensa em narcolepsia. O próximo exame mais adequado é:

O DADO QUE DECIDE

tempo de registro válido de 3 horas e 10 minutos

Resolução. A poligrafia domiciliar com índice de 4 eventos/hora é o exame tranquilizador plantado no meio do caso e leva a procurar outra causa de sonolência, como narcolepsia. Mas a poligrafia tipo 3 não registra o sono: divide os eventos pelo tempo de registro, e não pelo tempo dormido, e por isso subestima o índice, sobretudo quando o paciente fica acordado e o registro válido é curto, como aqui. Com probabilidade pré-teste alta (ronco, apneias presenciadas, obesidade, pescoço largo, hipertensão resistente, sonolência importante), um exame domiciliar negativo ou tecnicamente inadequado não exclui apneia obstrutiva, e a recomendação é a polissonografia completa em laboratório. O teste de latências múltiplas só se interpreta depois de afastada a apneia por uma polissonografia válida na noite anterior. Tratar sem diagnóstico, com CPAP ou aparelho intraoral, não se justifica.

A) Teste de latências múltiplas do sono ARMADILHA
Errada. É a armadilha do exame tranquilizador: o teste de latências múltiplas investiga narcolepsia, mas exige polissonografia prévia que afaste apneia, e a poligrafia curta não fez isso.

B) CPAP com titulação automática domiciliar

Errada. Seria o tratamento na apneia obstrutiva moderada a grave confirmada; ainda não há diagnóstico.

C) Aparelho intraoral de avanço mandibular

Errada. É opção para apneia leve a moderada confirmada ou intolerância ao CPAP; não substitui o diagnóstico e seria pouco eficaz numa apneia provavelmente grave.

D) Polissonografia completa em laboratório CORRETA

Correta. Alta probabilidade pré-teste com poligrafia domiciliar negativa e registro curto: polissonografia completa em laboratório.

Para levar. Poligrafia domiciliar negativa ou tecnicamente inadequada não afasta apneia obstrutiva quando a suspeita é alta: o passo seguinte é a polissonografia completa em laboratório.

AASM Clinical Practice Guideline for Diagnostic Testing for Adult Obstructive Sleep Apnea (2017); AASM Clinical Practice Guideline for Treatment of Central Disorders of Hypersomnolence (2021).

Revisa: UERJ recorrente: SAHOS e o diagnóstico polissonográfico, com o exame tranquilizador no meio do caso (padrão negativo no meio)

45

Endocrinologia · Normetanefrina plasmática 1,5 vez o limite em hipertensa com crises de ansiedade em uso de tricíclico para enxaqueca: retirar a droga e repetir antes de qualquer imagem

Droga a deduzir **Gabarito D**

Mulher de 42 anos, hipertensa há 2 anos, controlada com anlodipino 5 mg, é encaminhada por episódios de palpitação, cefaleia e sudorese, que relaciona a momentos de ansiedade. Usa há 1 ano, à noite, o comprimido que o neurologista prescreveu para profilaxia da enxaqueca e para ajudar no sono, e desde então tem boca seca e constipação. Nega uso de descongestionantes, cocaína ou anfetaminas. PA 134 × 84 mmHg, FC 88 bpm, sem hipotensão postural, sem manchas café com leite ou neurofibromas. Metanefrinas livres plasmáticas colhidas em decúbito após 30 minutos de repouso: metanefrina 0,38 nmol/L (até 0,45) e normetanefrina 1,34 nmol/L (até 0,90). Glicemia, TSH e cálcio normais. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

desde então tem boca seca e constipação

Resolução. Crises de palpitação, cefaleia e sudorese com normetanefrina elevada parecem confirmar feocromocitoma, e o passo seguinte seria localizar o tumor na tomografia. Dois dados pedem cautela. A elevação é discreta, cerca de 1,5 vez o limite e só da normetanefrina, faixa em que falsos positivos predominam; tumores costumam elevar os metabólitos acima de 3 a 4 vezes. E o comprimido noturno para enxaqueca e sono que trouxe boca seca e constipação é um antidepressivo tricíclico (amitriptilina), que bloqueia a recaptação de noradrenalina e eleva a normetanefrina. A conduta é retirar a droga, com substituição se necessário, aguardar cerca de 2 semanas e repetir a dosagem; o teste de supressão com clonidina é a alternativa quando a droga não pode ser suspensa. Imagem antes de confirmar o excesso bioquímico encontra incidentalomas e não esclarece nada.

A) Fenoxibenzamina e depois imagem adrenal

Errada. O alfabloqueio é o preparo pré-operatório de feocromocitoma confirmado e localizado; não há diagnóstico ainda.

B) Cintilografia com metaiodobenzilguanidina
Errada. A cintilografia funcional serve para doença metastática ou multifocal, ou para tumor confirmado com tomografia negativa, e não como primeiro exame.

C) Tomografia de abdome com contraste ARMADILHA
Errada. É a armadilha: a tomografia localiza o feocromocitoma confirmado bioquimicamente, e aqui a elevação discreta tem uma droga que a explica.

D) Retirar a droga noturna e repetir a dosagem CORRETA
Correta. Normetanefrina pouco elevada em usuária de tricíclico (boca seca e constipação desde o início) é falso positivo provável: retira-se a droga e repete-se a dosagem.

Para levar. Metanefrinas pouco elevadas (abaixo de 3 vezes o limite) pedem revisão de drogas antes de imagem: tricíclicos, inibidores da recaptação de noradrenalina e antipsicóticos elevam a normetanefrina.

Lenders JWM et al. Pheochromocytoma and paraganglioma: an Endocrine Society Clinical Practice Guideline. J Clin Endocrinol Metab 2014; Eisenhofer G et al. Biochemical diagnosis of chromaffin cell tumors in patients at high and low risk of disease. Clin Chem 2018.

Revisa: UERJ recorrente: feocromocitoma e NEM + S3 q38; a droga que falseia o exame, a deduzir pelos efeitos anticolinérgicos

---

46 Nefrologia · Rabdomiólise no idoso que caiu, com mialgia desde antes da queda: interação de sinvastatina com claritromicina

Grade X / Y **Gabarito C**

Homem de 74 anos, com dislipidemia e doença arterial coronariana, usa sinvastatina 40 mg/dia há anos, AAS e losartana. Há 6 dias recebeu claritromicina na UPA por pneumonia comunitária, com melhora da febre. Desde o quarto dia de antibiótico refere dor difusa e fraqueza nas coxas, e há 2 dias nota urina escura. Hoje escorregou no banheiro e permaneceu 40 minutos no chão até ser socorrido. PA 128 × 76 mmHg, FC 88 bpm, afebril, dor à palpação das coxas, sem déficit neurológico focal nem sinais de síndrome compartimental. Exames: CK 46.000 U/L, creatinina 2,9 mg/dL (basal 1,0), K 5,4 mEq/L, cálcio 7,9 mg/dL, fósforo 6,1 mg/dL, hemoglobina 13,8 g/dL, LDH 980 U/L, haptoglobina normal. Fita urinária com sangue 3+; sedimento com 1 a 2 hemácias por campo e cilindros granulosos pigmentados. A causa da lesão renal e o fator desencadeante mais provável são, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

Desde o quarto dia de antibiótico refere dor difusa e fraqueza nas coxas

Resolução. A queda com permanência no chão é verdadeira e é o desencadeante que se costuma lembrar na rabdomiólise do idoso. Mas 40 minutos de imobilização não explicam CK de 46.000 U/L, e a cronologia derruba essa causa: a mialgia começou no quarto dia de claritromicina e a urina escureceu 2 dias antes da queda, que foi consequência da fraqueza, e não causa. A claritromicina inibe fortemente o CYP3A4 e eleva muito o nível da sinvastatina, que é metabolizada por essa via; a combinação é contraindicada. A fita positiva para sangue com quase nenhuma hemácia no sedimento indica pigmento heme, e a haptoglobina e a hemoglobina normais afastam hemólise, deixando a mioglobina. A conduta inclui suspender ambas as drogas, hidratação vigorosa e controle do potássio.

A) Mioglobinúria / imobilização após a queda ARMADILHA

Errada. É a armadilha da queda: a imobilização curta seria o gatilho de quem é achado no chão após horas, mas a mialgia e a urina escura precederam a queda.

B) Hemoglobinúria / hemólise pela claritromicina

Errada. Hemoglobinúria daria haptoglobina consumida e queda da hemoglobina; aqui ambas estão normais.

C) Mioglobinúria / sinvastatina com claritromicina CORRETA

Correta. Mialgia iniciada no quarto dia de claritromicina em usuário de sinvastatina, CK de 46.000 e fita com heme sem hemácias indicam rabdomiólise pela interação no CYP3A4.

D) Glomerulonefrite / pneumonia em atividade

Errada. Glomerulonefrite pós-infecciosa daria hematúria dismórfica abundante e CK normal; aqui o sedimento quase não tem hemácias.

Para levar. Fita com sangue positiva e sedimento sem hemácias é pigmento; na rabdomiólise do idoso, procure a interação de estatina com inibidor do CYP3A4 (claritromicina, azólicos, diltiazem) antes de culpar a queda.

Bosch X, Poch E, Grau JM. Rhabdomyolysis and acute kidney injury. N Engl J Med 2009; 2018 AHA/ACC Guideline on the Management of Blood Cholesterol (seção de interações das estatinas).

Revisa: UERJ recorrente: rabdomiólise na IRA + S3 q28 (droga a deduzir por interação)

47

Gastroenterologia e hepatologia · Hepatite autoimune com aminotransferases normais há 2 anos e IgG ainda alta: sem remissão bioquímica completa, manter a azatioprina

Omissão **Gabarito A**

Mulher de 42 anos, com hepatite autoimune tipo 1 diagnosticada há 3 anos (FAN 1:640, antimúsculo liso 1:160, IgG de 3.100 mg/dL e biópsia com hepatite de interface e infiltrado plasmocitário), sem cirrose na época (elastografia de 6,1 kPa). Está em uso de azatioprina 100 mg e prednisona 5 mg ao dia, com boa adesão. Assintomática, deseja engravidar no próximo ano e pede para suspender as medicações. Nos últimos 24 meses, ALT e AST estiveram normais em todas as dosagens trimestrais (última ALT de 28 U/L, referência até 33). Exames atuais: bilirrubinas normais, albumina 4,1 g/dL, INR 1,0, plaquetas 230.000/mm³, leucócitos 5.400/mm³, IgG de 1.980 mg/dL (referência de 700 a 1.600). Elastografia atual de 5,8 kPa. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

IgG de 1.980 mg/dL (referência de 700 a 1.600)

Resolução. Dois anos de aminotransferases normais, fibrose mínima e o desejo de gestar parecem autorizar a retirada, e é isso que o apressado faz. Mas a remissão bioquímica completa na hepatite autoimune exige aminotransferases e IgG normais, e a IgG persistentemente alta indica atividade residual e alto risco de recaída após a suspensão. Só com remissão bioquímica completa sustentada por pelo menos 2 anos se discute a retirada, e a biópsia antes dela é opcional, sem papel quando a IgG já mostra que a remissão não foi atingida. A gestação não muda o raciocínio: a azatioprina é compatível com a gravidez, e a recaída da hepatite na gestação ou no puerpério é mais perigosa que a manutenção. O micofenolato é teratogênico e contraindicado em quem planeja engravidar.

A) Manter azatioprina e prednisona CORRETA

Correta. IgG acima do normal mostra que não há remissão bioquímica completa; mantém-se o esquema, que é seguro na gestação.

B) Biópsia hepática antes da retirada

Errada. A biópsia pode ser considerada antes da retirada em quem está em remissão bioquímica completa, o que não é o caso.

C) Retirar a azatioprina gradualmente ARMADILHA

Errada. Seria discutida com aminotransferases e IgG normais por pelo menos 2 anos; a IgG elevada prevê recaída.

D) Trocar azatioprina por micofenolato

Errada. Micofenolato é a segunda linha na intolerância ou resposta inadequada à azatioprina e é teratogênico, impróprio para quem planeja gestar.

Para levar. Remissão bioquímica na hepatite autoimune é ALT e IgG normais; com IgG alta não se retira a imunossupressão, e a azatioprina se mantém na gestação.

EASL Clinical Practice Guidelines on the management of autoimmune hepatitis, 2025; AASLD Practice Guidance on autoimmune hepatitis, 2025.

Revisa: UERJ recorrente: hepatite autoimune, aqui pelo critério de remissão que inclui a IgG

---

48 Reumatologia · Anafilaxia a vespa só com hipotensão e triptase basal elevada: imunoterapia com veneno e pesquisa de mastocitose clonal

Grade X / Y **Gabarito D**

Homem de 47 anos, sem doenças conhecidas e sem medicações, foi picado por uma vespa no jardim há 3 semanas. Em 10 minutos teve tontura e síncope, com PA de 64 × 30 mmHg na chegada do resgate, sem urticária, angioedema, sibilância ou sintomas gastrointestinais; recebeu adrenalina intramuscular e se recuperou em 1 hora. Antes, só havia tido reações locais a picadas. A triptase colhida 1 hora após o evento foi de 48 ng/mL; a triptase basal hoje é de 26 ng/mL (referência: até 11,4). IgE específica para veneno de Vespula de 2,1 kUA/L. Exame físico normal, sem lesões cutâneas pigmentadas e sem hepatoesplenomegalia; hemograma e função hepática normais. Já recebeu prescrição de adrenalina autoinjetável. Em relação à imunoterapia com veneno e à investigação adicional, a conduta mais adequada é, respectivamente:

O DADO QUE DECIDE

a triptase basal hoje é de 26 ng/mL (referência: até 11,4)

Resolução. A falta de urticária leva alguns a duvidar de anafilaxia, mas hipotensão súbita minutos após exposição a alérgeno conhecido já define o quadro, e a reação sistêmica grave a himenóptero com IgE específica positiva indica imunoterapia com veneno, que reduz muito o risco de nova reação. A armadilha é parar aí. Anafilaxia a himenóptero com colapso cardiovascular sem sintomas cutâneos, somada à triptase basal acima de 20 ng/mL, é o perfil de doença clonal de mastócitos, mesmo sem lesões de pele. A investigação inclui a pesquisa da mutação KIT D816V em sangue periférico e, conforme o resultado, biópsia de medula. A presença de mastocitose muda a imunoterapia: ela deve ser mantida por tempo indefinido, e não de 3 a 5 anos.

A) Não indicada / pesquisa de mastocitose clonal
Errada. A investigação está certa, mas a reação sistêmica com hipotensão e IgE positiva indica imunoterapia, que é ainda mais importante na mastocitose.

B) Indicada / sem investigação adicional ARMADILHA
Errada. A imunoterapia está indicada, mas a triptase basal de 26 ng/mL com colapso sem pele pede investigar mastocitose clonal, que muda a duração do tratamento.

C) Não indicada / sem investigação adicional
Errada. Deixaria um paciente com reação grave e provável doença clonal só com a adrenalina autoinjetável.

D) Indicada / pesquisa de mastocitose clonal CORRETA
Correta. Reação sistêmica grave com IgE positiva indica imunoterapia com veneno, e a triptase basal acima de 20 ng/mL com hipotensão isolada pede pesquisa de mastocitose.

Para levar. Anafilaxia a himenóptero com hipotensão sem urticária e triptase basal acima de 20 ng/mL: imunoterapia com veneno e pesquisa de mastocitose clonal (KIT D816V), e na mastocitose a imunoterapia é por tempo indefinido.

Sturm GJ et al. EAACI guidelines on allergen immunotherapy: Hymenoptera venom allergy, Allergy 2018; Golden DBK et al. Stinging insect hypersensitivity: a practice parameter update 2016; Valent P et al. Updated diagnostic criteria and classification of mast cell disorders, 2021.

Revisa: UERJ recorrente: imunologia e alergia (anafilaxia); padrão do aluno de parar no diagnóstico óbvio sem dar o passo seguinte

---

49 Cardiologia · TEP bilateral de baixo risco (sPESI zero, VD normal, troponina normal): alta precoce com anticoagulante oral direto

Omissão **Gabarito B**

Mulher de 36 anos, em uso de anticoncepcional oral combinado, fez artroscopia de joelho direito há 3 semanas. Há 2 dias tem dor pleurítica à direita e dispneia leve. Sem câncer, sem doença cardíaca ou pulmonar crônica, sem sangramento prévio. Ao exame: PA 124 × 78 mmHg, FC 92 bpm, FR 18 irpm, SatO2 96% em ar ambiente, temperatura 36,8 °C; panturrilha direita discretamente empastada. D-dímero de 3.200 ng/mL. Angiotomografia: falhas de enchimento em artérias lobares inferiores e em ramos segmentares dos dois pulmões, com relação VD/VE de 0,8 e sem refluxo de contraste para a veia cava inferior. Troponina I e BNP normais. Creatinina 0,7 mg/dL, plaquetas 248.000/mm³. Mora com o marido a 15 minutos do hospital e tem acesso garantido ao retorno. A dor cede com dipirona. A conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE
relação VD/VE de 0,8

Resolução. Trombos bilaterais em artérias lobares e um D-dímero muito alto impressionam e levam a internar e pedir eco, mas a extensão do trombo na tomografia não define o risco do TEP. O risco se mede pela repercussão no ventrículo direito e pela gravidade clínica: ela tem sPESI zero (idade abaixo de 80 anos, sem câncer, sem doença cardiopulmonar crônica, FC abaixo de 110, PAS acima de 100 e saturação acima de 90%), relação VD/VE abaixo de 1 na própria angiotomografia e troponina e BNP normais. É TEP de baixo risco, e os critérios de Hestia são negativos: sem instabilidade, sem necessidade de oxigênio, sem risco hemorrágico, com dor controlada e suporte social. Nessa situação, a alta precoce com anticoagulante oral

direto é segura e recomendada. O anticoncepcional com estrogênio deve ser suspenso e trocado por método não estrogênico, e a anticoagulação dura pelo menos 3 meses, pois o fator de risco é transitório.

A) Trombólise sistêmica com alteplase
Errada. Trombólise sistêmica é para TEP de alto risco, com hipotensão ou choque, ou deterioração do risco intermediário-alto.

B) Alta precoce com rivaroxabana CORRETA
Correta. sPESI zero, VD/VE abaixo de 1 e biomarcadores normais definem baixo risco, com alta precoce e anticoagulante oral direto.

C) Internação com heparina não fracionada
Errada. Heparina não fracionada seria preferida se houvesse possibilidade de reperfusão iminente ou clearance de creatinina abaixo de 30 mL/min.

D) Internação com enoxaparina e ecocardiograma ARMADILHA
Errada. É a armadilha da carga trombótica bilateral; o ecocardiograma não acrescenta quando a tomografia já mostra VD normal e os biomarcadores são normais.

Para levar. O risco do TEP é da clínica e do VD, não da extensão do trombo: sPESI zero com VD normal e biomarcadores normais permite alta precoce com anticoagulante oral direto.

2019 ESC Guidelines for the diagnosis and management of acute pulmonary embolism; ASH 2020 guidelines for management of venous thromboembolism: treatment; CHEST Guideline and Expert Panel Report on Antithrombotic Therapy for VTE Disease, 2021.

Revisa: UERJ recorrente: TEP de baixo risco + S1 q84 (TEP x tamponamento, agora o risco do TEP verdadeiro)

---

50 Infectologia · Meningite tuberculosa no diabético descompensado sem HIV: corticoide mesmo assim e tratamento por 12 meses

Grade X / Y **Gabarito C**

Homem de 56 anos, com diabetes tipo 2 em uso de insulina (HbA1c de 9,8%), sorologia para HIV não reagente, tem cefaleia e febre baixa há 3 semanas; há 4 dias surgiram diplopia e sonolência. Temperatura 37,9 °C, Glasgow 13, rigidez de nuca, paralisia do VI nervo à direita, sem outros déficits. Glicemia capilar de 260 mg/dL. TC de crânio: realce leptomeníngeo nas cisternas da base e dilatação ventricular leve, sem lesões com efeito de massa. Líquor: 280 células/mm³ com 70% de linfócitos, proteína 240 mg/dL, glicose 32 mg/dL com glicemia simultânea de 210 mg/dL, ADA 14 U/L, teste rápido molecular com Mycobacterium tuberculosis detectado, sem resistência à rifampicina. O endocrinologista pede que se evite corticoide pelo controle glicêmico difícil. Quanto ao uso de corticoide sistêmico e à duração total do tratamento antituberculose, respectivamente, a conduta mais adequada é:

O DADO QUE DECIDE

Mycobacterium tuberculosis detectado, sem resistência à rifampicina

Resolução. O pedido do endocrinologista é razoável à primeira vista, e quem lembra que a meningite muda a duração mas esquece o corticoide marca 12 meses sem ele. A meningite tuberculosa confirmada pelo teste molecular, na pessoa sem HIV, tem indicação de corticoide em todos os graus de gravidade, porque reduz a mortalidade; aqui ainda há rebaixamento, nervo craniano acometido e hidrocefalia, sinais de doença avançada. O diabetes descompensado não é contraindicação: exige insulina ajustada e monitorização, e não

suspender o que reduz morte. O esquema brasileiro para meningoencefalite tuberculosa é 2 meses de RHZE seguidos de 10 meses de RH, 12 meses no total, com prednisona ou dexametasona por 4 a 8 semanas com retirada gradual. A razão glicorraquia/glicemia de 0,15 confirma o consumo de glicose, mesmo com a glicose liquórica falsamente tranquilizadora pela hiperglicemia.

A) Sem corticoide / 6 meses
Errada. Seria o esquema da tuberculose pulmonar sem complicação; a meningite exige 12 meses e corticoide.

B) Com corticoide / 6 meses
Errada. Acerta o corticoide, mas 6 meses é o tempo da forma pulmonar; a meningoencefalite pede 2RHZE seguido de 10RH.

C) Com corticoide / 12 meses CORRETA
Correta. Meningite tuberculosa: corticoide adjuvante, mesmo com diabetes, e 12 meses de tratamento.

D) Sem corticoide / 12 meses ARMADILHA
Errada. É a armadilha do diabetes: acerta a duração, mas abrir mão do corticoide aumenta a mortalidade, e a glicemia se controla com insulina.

Para levar. Meningite tuberculosa: corticoide adjuvante para todos os graus na pessoa sem HIV, e 12 meses de tratamento (2RHZE seguido de 10RH); diabetes pede ajuste de insulina, e não retirar o corticoide.

Ministério da Saúde, Manual de Recomendações para o Controle da Tuberculose no Brasil, 2ª ed. (2019, atualizado 2022); WHO Consolidated Guidelines on Tuberculosis, Module 4: Treatment (2022); ATS/CDC/ERS/IDSA Treatment of Drug-Susceptible Tuberculosis (2016).

Revisa: UERJ recorrente: meningite tuberculosa (corticoide e duração), com a comorbidade que parece contraindicar o padrão